ΚΥΡΙΟ ΥΛΙΚΟ

120 Έτοιμα Πρότυπα Γνωματεύσεων

120 πρότυπα γνωμάτευσης για ακτινογραφία, αξονική, μαγνητική και υπερηχογράφημα/Doppler. Τα πεδία Τεχνική, Σύγκριση, Ευρήματα και Συμπέρασμα είναι έτοιμα· εσείς συμπληρώνετε μόνο τις αγκύλες. Στόχος: μια γνωμάτευση που ο επιμελητής σας δεν θα χρειαστεί να ξαναγράψει από την αρχή.

Περιεχόμενα

Πώς χρησιμοποιούνται τα πρότυπα

Ενότητα 1 · Απλή ακτινογραφία — 30 πρότυπα

Ενότητα 2 · Αξονική τομογραφία — 35 πρότυπα

Ενότητα 3 · Μαγνητική τομογραφία — 25 πρότυπα

Ενότητα 4 · Υπερηχογράφημα και Doppler — 30 πρότυπα

Επόμενο βήμα

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Πώς χρησιμοποιούνται τα πρότυπα

Κάθε πρότυπο είναι η γραπτή μορφή της μεθόδου 4 βημάτων: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ · ΣΑΡΩΣΤΕ · ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ · ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ.

> *Το πρότυπο δεν αντικαθιστά τη σκέψη· σας επιτρέπει να γράψετε αυτό που σκεφτήκατε πλήρως και με τη σειρά που περιμένει ο επιμελητής σας.*

ΠΕΔΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟΥ	ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ	ΤΙ ΓΡΑΦΕΤΕ
Τεχνική	ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	Εξέταση, προβολές ή ακολουθίες, σκιαγραφικό και φάση, τεχνική επάρκεια. Εάν είναι ανεπαρκής, γράψτε το ρητά.
Σύγκριση	ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ · Συγκρίνετε	Ημερομηνία και απεικονιστική μέθοδος της προηγούμενης εξέτασης· αν δεν υπάρχει, «δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση».
Ευρήματα	ΣΑΡΩΣΤΕ + ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ	Κάθε περιοχή κάθε φορά με την ίδια σειρά· σωστός όρος (πυκνότητα / σήμα / ηχογένεια), εντόπιση, μέγεθος, όρια. Γράψτε και τα σημαντικά αρνητικά ευρήματα.
Συμπέρασμα	ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ	Απάντηση στο κλινικό ερώτημα, το σημαντικότερο εύρημα πρώτο, εφόσον χρειάζεται διαφορική διάγνωση και σύσταση. Εάν υπάρχει επείγον εύρημα, σε ποιον και τι ώρα ενημερώθηκε.

Αγκύλες

Στα πρότυπα, πεδία όπως **[δεξιά/αριστερά]**, **[.. mm]**, **[ημερομηνία]**, **[ώρα]** είναι πεδία που αφορούν τον συγκεκριμένο ασθενή. Οι επιλογές δίνονται με κάθετο: κρατήστε την κατάλληλη και διαγράψτε τις υπόλοιπες. Πριν υπογράψετε τη γνωμάτευση, δεν πρέπει να μείνει ούτε μία αγκύλη στο κείμενο.

1. **Επιλέξτε το σωστό πρότυπο** — ανάλογα με την εξέταση και το κύριο εύρημα. Σε φυσιολογική εξέταση ξεκινήστε με το πρότυπο «Φυσιολογικό».

2. **Συμπληρώστε τα πεδία Τεχνική και Σύγκριση** — γράψτε την ημερομηνία της προηγούμενης εξέτασης μόνο αν την ανοίξατε πραγματικά.

3. **Οργανώστε τα ευρήματα σύμφωνα με τη δική σας σάρωση** — προσθέστε ό,τι εύρημα δεν υπάρχει στο πρότυπο και διαγράψτε ό,τι εύρημα δεν είδατε.

4. **Γράψτε το συμπέρασμα με βάση το κλινικό ερώτημα** — μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη πρόταση από την Τράπεζα 200 Συμπερασμάτων Γνωμάτευσης.

5. **Εφαρμόστε τη Λίστα Ελέγχου Γνωμάτευσης σε Μία Σελίδα** — στη συνέχεια υπογράψτε ή στείλτε τη στον επιμελητή σας.

Η παγίδα της αντιγραφής-επικόλλησης

Τα λάθη πλευράς, μετρήσεων και ημερομηνιών προέρχονται κυρίως από κείμενο που έμεινε από το πρότυπο. Επαληθεύστε μία προς μία κάθε πρόταση του προτύπου με την εικόνα που βλέπετε· μην αφήνετε κάτι που δεν είδατε επειδή «υπάρχει στο πρότυπο».

Η πρακτική του ιδρύματός σας προηγείται

Εάν η μορφή γνωμάτευσης, τα συστήματα ταξινόμησης και η ορολογία του τμήματός σας διαφέρουν από αυτά τα πρότυπα, εφαρμόζετε πάντα τη μορφή του τμήματός σας. Προσαρμόστε τα πρότυπα ανάλογα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Απλή ακτινογραφία

30 πρότυπα: 4 φυσιολογικά, 26 συχνά ευρήματα της εφημερίας και της ρουτίνας.

001 Ακτινογραφία θώρακα PA · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Ακτινογραφίες θώρακα ενηλίκων στις οποίες δεν διαπιστώνετε παθολογία, σε θωρακικό πόνο, βήχα ή προεγχειρητικό έλεγχο.

Τεχνική: Όρθια ακτινογραφία θώρακα PA. Επαρκής εισπνοή και διεισδυτικότητα, χωρίς σημαντική στροφή.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Η τραχεία στη μέση γραμμή. Το μέγεθος της καρδιάς εντός φυσιολογικών ορίων. Το μεσοθωράκιο και οι πύλες φυσιολογικής εμφάνισης. Δεν διαπιστώνεται πύκνωση, μάζα ή όζος στο παρέγχυμα αμφότερων των πνευμόνων. Οι πλευροδιαφραγματικές γωνίες είναι ελεύθερες. Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας. Οι θόλοι του διαφράγματος έχουν ομαλό περίγραμμα. Δεν υπάρχει σημαντική παθολογία στα απεικονιζόμενα οστά.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε οξεία καρδιοπνευμονική παθολογία στην ακτινογραφία θώρακα.

002 Όρθια απλή ακτινογραφία κοιλίας · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Ακτινογραφίες στις οποίες δεν βλέπετε παθολογία, ως απάντηση στο ερώτημα απόφραξης ή ελεύθερου αέρα σε κοιλιακό άλγος.

Τεχνική: Όρθια απλή ακτινογραφία κοιλίας· οι θόλοι του διαφράγματος εντός του πεδίου απεικόνισης.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα. Δεν διαπιστώνονται διατεταμένες έλικες εντέρου με υδραερικά επίπεδα. Παρατηρείται αέρας στο παχύ έντερο και στο ορθό. Δεν υπάρχει εμφανής εικόνα ακτινοσκιερού λίθου. Οι σκιές των ψοϊτών μυών διακρίνονται. Τα απεικονιζόμενα οστά είναι φυσιολογικά.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκαν ευρήματα απόφραξης ή ελεύθερου αέρα στην απλή ακτινογραφία κοιλίας.

003 Ακτινογραφία καρπού · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Ακτινογραφίες καρπού μετά από πτώση ή διάστρεμμα στις οποίες δεν βλέπετε κάταγμα ή εξάρθρημα.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] ακτινογραφίες καρπού AP και πλάγια.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται γραμμή οξέος κατάγματος στην περιφερική κερκίδα, την ωλένη και τα οστά του καρπού. Τα κερκιδοκαρπικά και μεσοκαρπικά διαστήματα διατηρούνται, η ευθυγράμμιση είναι φυσιολογική. Δεν υπάρχει σημαντικό οίδημα μαλακών μορίων.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] καρπός: δεν διαπιστώνεται οξεία οστική παθολογία. Εάν υπάρχει κλινική υποψία κατάγματος σκαφοειδούς, το αφανές κάταγμα δεν μπορεί να αποκλειστεί με την ακτινογραφία· συνιστάται κλινική παρακολούθηση και, εφόσον χρειάζεται, συμπληρωματική εξέταση.

004 Ακτινογραφία γόνατος · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά κάκωσης ή πόνου γόνατος στα οποία δεν βλέπετε οστική παθολογία.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] ακτινογραφίες γόνατος AP και πλάγια.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται κάταγμα ή εξάρθρημα. Τα κνημομηριαία και επιγονατιδομηριαία διαστήματα διατηρούνται. Δεν υπάρχουν ευρήματα σημαντικής συλλογής στην υπερεπιγονατιδική περιοχή. Η οστική μεταλλοποίηση είναι φυσιολογική.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] γόνατο: στην ακτινογραφία δεν διαπιστώνεται οξεία οστική παθολογία.

005 Ακτινογραφία θώρακα PA · Πνευμοθώρακας

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου στο στήθος, δύσπνοιας, τραύματος ή μετά από επέμβαση στα οποία βλέπετε υπεζωκοτική γραμμή. Μπορεί να απαιτείται ενημέρωση.

Τεχνική: Όρθια ακτινογραφία θώρακα PA.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] ημιθωράκιο: πνευμοθώρακας χωρίς αγγειακή σκιαγράφηση του πνεύμονα έξω από την υπεζωκοτική γραμμή· στο επίπεδο της κορυφής, απόσταση υπεζωκοτικής γραμμής από θωρακικό τοίχωμα [.. mm]. Μετατόπιση μεσοθωρακίου [δεν παρατηρείται/προς την αντίθετη πλευρά]. Κάταγμα πλευράς [δεν παρατηρείται/στην ... πλευρά].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] πνευμοθώρακας. Ακτινολογικά ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα υπό τάση [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

006 Ακτινογραφία θώρακα · Ευρήματα πνευμοθώρακα υπό τάση

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μεγάλου πνευμοθώρακα με συνοδό μετατόπιση του μεσοθωρακίου. Ο πνευμοθώρακας υπό τάση είναι κλινική διάγνωση· μπορεί να έχει αντιμετωπιστεί πριν από την ακτινογραφία.

Τεχνική: [PA/AP παρά την κλίνη] ακτινογραφία θώρακος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] ημιθωράκιο: εκτεταμένος πνευμοθώρακας· ο ομόπλευρος πνεύμονας είναι συμπτυγμένος προς την πύλη. Το μεσοθωράκιο και η τραχεία έχουν παρεκτοπιστεί προς την αντίθετη πλευρά, το ομόπλευρο ημιδιάφραγμα είναι επιπεδωμένο και τα μεσοπλεύρια διαστήματα διευρυμένα.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] εκτεταμένος πνευμοθώρακας και ακτινολογικά ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα υπό τάση. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα] τηλεφωνικά.

007 Ακτινογραφία θώρακα PA · Πλευριτική συλλογή

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με αμβλύνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας ή εικόνα μηνίσκου.

Τεχνική: Όρθια PA [± πλάγια] ακτινογραφία θώρακος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά/Αμφοτερόπλευρα] αμβλύνση της πλευροδιαφραγματικής γωνίας και σκίαση σχήματος μηνίσκου με κοίλο άνω όριο, συμβατή με [μικρή/μέτρια/μεγάλη] ποσότητα υπεζωκοτικής συλλογής. Δεν είναι δυνατή η διάκριση υποκείμενης πύκνωσης στον παρακείμενο πνεύμονα. Μεσοθωράκιο [φυσιολογικό/παρεκτοπισμένο προς την αντίθετη πλευρά].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά/Αμφοτερόπλευρα] [μικρή/μέτρια/μεγάλη] ποσότητα υπεζωκοτικής συλλογής. Υποκείμενη παρεγχυματική παθολογία δεν μπορεί να αποκλειστεί στην ακτινογραφία· συνιστάται συσχέτιση με την κλινική εικόνα και, εφόσον χρειάζεται, με υπερηχογράφημα.

008 Ακτινογραφία θώρακα PA · Λοβώδης πύκνωση

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με πυρετό, βήχα και σκίαση που περιέχει αεροβρογχόγραμμα.

Τεχνική: Όρθια PA [± πλάγια] ακτινογραφία θώρακος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [άνω/μέσο/κάτω] λοβός: περιοχή ομοιογενούς πύκνωσης με αεροβρογχογράμματα. Ο όγκος του λοβού διατηρείται. [Δεν παρατηρείται συνοδός πλευριτική συλλογή/μικρή πλευριτική συλλογή].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] πύκνωση· σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα μπορεί να είναι συμβατή με πνευμονία. Ο ακτινολογικός έλεγχος μετά τη θεραπεία συνιστάται κατά την κλινική κρίση.

009 Ακτινογραφία θώρακα PA · Ατελεκτασία

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε σκίαση με συνοδά ευρήματα απώλειας όγκου.

Τεχνική: Όρθια PA [± πλάγια] ακτινογραφία θώρακος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός]: σκίαση με απώλεια όγκου· στη μεσολόβια σχισμή [παρεκτόπιση], στην ομόπλευρη πύλη [προς τα άνω/προς τα κάτω] έλξη και ανάσπαση του ημιδιαφράγματος.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] λοβός: ευρήματα συμβατά με ατελεκτασία. Συνιστάται κλινική συσχέτιση και, εφόσον χρειάζεται, αξονική τομογραφία θώρακος για κεντρική αποφρακτική αιτία.

010 Ακτινογραφία θώρακα · Καρδιομεγαλία

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία η καρδιακή σκιά φαίνεται μεγάλη στην PA λήψη. Στην AP λήψη το μέγεθος της καρδιάς μπορεί να είναι παραπλανητικό· γράψτε το στη γνωμάτευση.

Τεχνική: [PA/AP] ακτινογραφία θώρακος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ο καρδιοθωρακικός δείκτης είναι αυξημένος. Πνευμονικές αγγειακές δομές [φυσιολογικές/διευρυσμένες]. Πλευριτική συλλογή [δεν παρατηρείται/...].

Συμπέρασμα: Καρδιομεγαλία [στην PA λήψη]. Η διάκριση από περικαρδιακή συλλογή δεν είναι δυνατή στην ακτινογραφία· εφόσον υπάρχει κλινική ένδειξη, συνιστάται συσχέτιση με υπερηχοκαρδιογράφημα.

011 Ακτινογραφία θώρακα · Πνευμονικό οίδημα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με δύσπνοια ή υποψία καρδιακής ανεπάρκειας ή υπερφόρτωσης υγρών.

Τεχνική: [PA/AP παρά την κλίνη] ακτινογραφία θώρακος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Αμφοτερόπλευρες περιπυλαίες σκιάσεις με μορφή πτερύγων πεταλούδας· αύξηση της διάμεσης σκιαγράφησης (γραμμές Kerley B), περιβρογχική πάχυνση και ανακατανομή της αιμάτωσης προς τα άνω πνευμονικά πεδία. Αμφοτερόπλευρα [μικρής ποσότητας] υπεζωκοτική συλλογή. Μέγεθος καρδιάς [αυξημένο/φυσιολογικό].

Συμπέρασμα: Ευρήματα ενδεικτικά πνευμονικού οιδήματος· πιθανώς συμβατά με καρδιογενές οίδημα. Συνιστάται κλινική συσχέτιση.

012 Ακτινογραφία θώρακα PA · Μάζα πνεύμονα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε στρογγυλή σκίαση με εκτιμήσιμα όρια.

Τεχνική: Όρθιες ακτινογραφίες θώρακα PA και πλάγια.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [άνω/μέσο/κάτω] ζώνη: [.. mm] μεγέθους, [ομαλό/λοβωτό/ακιδωτό] περίγραμμα, στρογγυλή σκίαση. Επασβέστωση [δεν παρατηρείται]. Διεύρυνση πυλών ή μεσοθωρακίου [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Πλευριτική συλλογή [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Καταστροφή παρακείμενων πλευρών [δεν παρατηρείται].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] πνεύμονας [ζώνη]: [.. mm] χωροκατακτητική βλάβη. Για περαιτέρω αξιολόγηση συνιστάται αξονική τομογραφία θώρακος με σκιαγραφικό.

013 Ακτινογραφία θώρακα PA · Κοιλοτική βλάβη

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά όπου βλέπετε βλάβη με τοίχωμα που περιέχει αέρα.

Τεχνική: Όρθια PA [± πλάγια] ακτινογραφία θώρακος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [άνω/μέσο/κάτω] ζώνη: τοίχωμα [λεπτό/παχύ, ανώμαλο] κοιλοτική βλάβη· εντός της επίπεδο αέρα-υγρού [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Περιξ [πύκνωση/οζώδεις σκιάσεις].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [ζώνη]: κοιλοτική βλάβη. Στη διαφορική διάγνωση περιλαμβάνονται λοιμώδεις διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης, πνευμονικό απόστημα και κοιλοτικό νεόπλασμα· συνιστάται κλινική και μικροβιολογική συσχέτιση και αξονική τομογραφία θώρακος.

014 Ακτινογραφία θώρακα · Κάταγμα πλευράς

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από θωρακική κάκωση στα οποία βλέπετε διακοπή της συνέχειας του φλοιού.

Τεχνική: Ακτινογραφία θώρακα PA [± ακτινογραφία πλευρών].

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [..] η πλευρά [πρόσθιο/πλάγιο/οπίσθιο] τόξο [χωρίς παρεκτόπιση/με παρεκτόπιση] γραμμή κατάγματος. Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας. Υπεζωκοτικό υγρό υπέρ αιμοθώρακα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Υποδόριο εμφύσημα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [..] η πλευρά: κάταγμα· δεν παρατηρείται συνοδός πνευμοθώρακας. Η ευαισθησία της απλής ακτινογραφίας στην ανάδειξη καταγμάτων πλευρών είναι περιορισμένη.

015 Ακτινογραφία θώρακα παρά την κλίνη · Θέση ενδοτραχειακού σωλήνα

Πότε χρησιμοποιείται: Ασθενείς εντατικής και επειγόντων στους οποίους ζητείται έλεγχος του άκρου του σωλήνα μετά τη διασωλήνωση.

Τεχνική: Ακτινογραφία θώρακα ΑΡ παρά την κλίνη.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα σε σχέση με την τρόπιδα: [.. cm] πάνω από την τρόπιδα, στη μέση γραμμή της τραχείας. [Το άκρο του ρινογαστρικού σωλήνα στην προβολή του στομάχου.] Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας. [Δεν υπάρχει νέα σκίαση.]

Συμπέρασμα: Το άκρο του ενδοτραχειακού σωλήνα σε σχέση με την τρόπιδα: [.. cm] πάνω από [σε κατάλληλη θέση]. / Το άκρο του σωλήνα [στον δεξιό κύριο βρόγχο] στην προβολή· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

016 Ακτινογραφία θώρακα παρά την κλίνη · Κεντρικός φλεβικός καθετήρας

Πότε χρησιμοποιείται: Έλεγχος της θέσης του άκρου και αποκλεισμός πνευμοθώρακα μετά από τοποθέτηση κεντρικού φλεβικού καθετήρα (ΚΦΚ).

Τεχνική: Ακτινογραφία θώρακα ΑΡ παρά την κλίνη.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [έσω σφαγίτιδας/υποκλειδίου] οδό: το άκρο του κεντρικού φλεβικού καθετήρα [της άνω κοίλης φλέβας/της κοιλοκολπικής συμβολής] στην προβολή. Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας. Καμία νέα διεύρυνση του μεσοθωρακίου.

Συμπέρασμα: Άκρο ΚΦΚ [της άνω κοίλης φλέβας] στην προβολή. Δεν παρατηρείται πνευμοθώρακας σχετιζόμενος με την παρέμβαση.

017 Ακτινογραφία θώρακα · Θέση ρινογαστρικού σωλήνα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία ζητείται έλεγχος του άκρου του ρινογαστρικού σωλήνα πριν από την έναρξη της σίτισης.

Τεχνική: Ακτινογραφία θώρακα και άνω κοιλίας ΑΡ παρά την κλίνη.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ο ρινογαστρικός σωλήνας διατρέχει στη μέση γραμμή την πορεία του οισοφάγου, διέρχεται το διάφραγμα και το άκρο του απεικονίζεται στο αριστερό άνω τεταρτημόριο, στην προβολή του στομάχου.

Συμπέρασμα: Το άκρο του ρινογαστρικού σωλήνα στην προβολή του στομάχου. / Το άκρο του σωλήνα [στον δεξιό κύριο βρόγχο/στον οισοφάγο] στην προβολή, όχι σε κατάλληλη θέση· πριν από τη χρήση ενημερώθηκε η κλινική ομάδα στις [ώρα].

018 Όρθια ακτινογραφία · Πνευμοπεριτόναιο

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά οξείας κοιλίας στα οποία βλέπετε ελεύθερο αέρα κάτω από το διάφραγμα. Απαιτείται επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Όρθια ακτινογραφία θώρακα / όρθια απλή ακτινογραφία κοιλίας.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αμφοτερόπλευρα] κάτω από τον θόλο του διαφράγματος παρατηρείται ακτινοδιαυγής περιοχή συμβατή με ελεύθερο αέρα.

Συμπέρασμα: Πνευμοπεριτόναιο (ελεύθερος αέρας). Εάν δεν υπάρχει πρόσφατο ιστορικό χειρουργείου ή επέμβασης, συνιστάται επείγουσα κλινική εκτίμηση για διάτρηση κοίλου σπλάχνου. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

019 Όρθια απλή ακτινογραφία κοιλίας · Απόφραξη λεπτού εντέρου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με εμέτους, διάταση και αδυναμία αποβολής αερίων και κοπράνων.

Τεχνική: Όρθια απλή ακτινογραφία κοιλίας [± σε ύπτια θέση].
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: Διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου κεντρικής εντόπισης με ορατές κερκιδωτές πτυχές (valvulae conniventes) και υδραερικά επίπεδα σε διαφορετικά ύψη. Αέρας στο παχύ έντερο [μειωμένος/δεν παρατηρείται]. Δεν υπάρχει ελεύθερος αέρας κάτω από το διάφραγμα.

Συμπέρασμα: Ευρήματα συμβατά με απόφραξη λεπτού εντέρου. Για την αξιολόγηση του επιπέδου, της αιτίας και των επιπλοκών συνιστάται αξονική τομογραφία κοιλίας με σκιαγραφικό.

020 Απλή ακτινογραφία κοιλίας · Υποψία συστροφής σιγμοειδούς

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με έντονη διάταση, ιδίως σε ηλικιωμένους ασθενείς, στα οποία βλέπετε γιγαντιαία έλικα παχέος εντέρου.

Τεχνική: Όρθια [± σε ύπτια θέση] απλή ακτινογραφία κοιλίας.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: Έλικα παχέος εντέρου έντονα διατεταμένη, με απώλεια της κολικής πτύχωσης, σε σχήμα ανεστραμμένου U, που εκτείνεται από την πύελο προς το άνω τεταρτημόριο (εικόνα κόκκου καφέ).

Συμπέρασμα: Ευρήματα ενδεικτικά συστροφής σιγμοειδούς. Συνιστάται επείγουσα κλινική εκτίμηση· για επιβεβαίωση και εκτίμηση επιπλοκών μπορεί να εξεταστεί αξονική. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

021 Απλή ακτινογραφία νεφρών-ουρητήρων-κύστης · Ακτινοσκιερός λίθος

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου στη λαγόνα στα οποία βλέπετε σκίαση στην πορεία του νεφρού ή του ουρητήρα.

Τεχνική: Απλή ακτινογραφία νεφρών-ουρητήρων-κύστης (ΝΟΚ).
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [νεφρού/πορείας ουρητήρα/πυέλου] στην προβολή [.. mm] μεγέθους σκιερή πυκνότητα.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [εντόπιση] στην προβολή: πυκνότητα πιθανώς συμβατή με ακτινοσκιερό λίθο. Συνιστάται συσχέτιση με υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό για διάκριση από φλεβόλιθο και αξιολόγηση απόφραξης.

022 Ακτινογραφία καρπού · Κάταγμα περιφερικής κερκίδας

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από πτώση στο χέρι στα οποία βλέπετε γραμμή κατάγματος στην περιφερική κερκίδα.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] ακτινογραφίες καρπού AP και πλάγια.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] μετάφυση περιφερικής κερκίδας: προς την αρθρική επιφάνεια [που επεκτείνεται/που δεν επεκτείνεται], [ραχιαία/παλαμιαία] γωνίωση: γραμμή κατάγματος. Κάταγμα στυλοειδούς απόφυσης ωλένης [συνυπάρχει/δεν συνυπάρχει]. Βράχυνση του κερκιδικού μήκους [υπάρχει/δεν υπάρχει].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] κάταγμα περιφερικής κερκίδας ([ενδαρθρικό/εξωαρθρικό], [ραχιαία/παλαμιαία] γωνίωση).

023 Ακτινογραφία καρπού · Κάταγμα σκαφοειδούς

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά ασθενών με ευαισθησία στην ανατομική ταμπακοθήκη στα οποία βλέπετε γραμμή κατάγματος στο σκαφοειδές.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] ακτινογραφίες καρπού AP, πλάγια και σκαφοειδούς.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Σκαφοειδές [μέσο τμήμα/εγγύς πόλο/άπω πόλο] επίπεδο [λεπτή/με παρεκτόπιση] γραμμή κατάγματος. Λιπώδης γραμμή σκαφοειδούς [εξαλειφθείσα/διατηρημένη].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] σκαφοειδές [μέσο τμήμα] κάταγμα. Στα κατάγματα του εγγύς πόλου συνιστάται ορθοπαιδική παρακολούθηση λόγω κινδύνου άσηπτης νέκρωσης.

024 Ακτινογραφία ισχίου · Κάταγμα αυχένα μηριαίου

Πότε χρησιμοποιείται: Ασθενείς, ιδίως ηλικιωμένοι, με πόνο στο ισχίο και αδυναμία βάδισης μετά από πτώση.

Τεχνική: Ακτινογραφίες πυέλου AP και [δεξιά/αριστερά] ακτινογραφίες πλάγιας ισχίου.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] αυχένας μηριαίου: [υποκεφαλικό/διαυχενικό/βασεοαυχενικό] γραμμή κατάγματος· [με παρεκτόπιση/χωρίς παρεκτόπιση, ενσφηνωμένο]. Άρθρωση ισχίου [ομαλή].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] κάταγμα αυχένα μηριαίου ([με παρεκτόπιση/χωρίς παρεκτόπιση]). Εάν η ακτινογραφία είναι αρνητική και η κλινική υποψία υψηλή, συνιστάται μαγνητική ή αξονική τομογραφία για αφανές κάταγμα.

025 Ακτινογραφία ώμου · Γληνοβραχιόνιο εξάρθρημα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από κάκωση ώμου στα οποία η κεφαλή του βραχιονίου δεν βρίσκεται σε αντιστοιχία με τη γληνοειδή κοιλότητα.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] ακτινογραφίες ώμου AP και [πλάγια ωμοπλάτης (Y)/μασχαλιαία] ακτινογραφίες.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] κεφαλή βραχιονίου σε σχέση με τη γλήνη: [πρόσθιο-κάτω/οπίσθιο] μοίρα· διαταραγμένη συμπλησίαση της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης. Κάταγμα μείζονος βραχιονίου ογκώματος [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. [Hill-Sachs/Bankart] οστική αλλοίωση υπέρ βλάβης [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [πρόσθια/οπίσθια] εξάρθρημα γληνοβραχιονίου. Συνιστάται ακτινογραφία ελέγχου μετά την ανάταξη.

026 Ακτινογραφία ποδοκνημικής · Κάταγμα σφυρού

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από διάστρεμμα στα οποία βλέπετε γραμμή κατάγματος στα σφυρά.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] ακτινογραφίες ποδοκνημικής AP, mortise και πλάγια.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [έξω σφυρό/περιφερική περόνη] επίπεδο, σε σχέση με τη συνδέσμωση [κάτω από/στο επίπεδο/πάνω από] [λοξή/εγκάρσια] γραμμή κατάγματος. Κάταγμα έσω σφυρού [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Διάστημα της ποδοκνημικής λαβίδας [συμμετρικό/διευρυμένο έσω]. Οίδημα μαλακών μορίων.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [έξω σφυρό] κάταγμα· ποδοκνημική λαβίδα (mortise) [διατηρημένη/διευρυσμένη].

027 Ακτινογραφία κνήμης · Κάταγμα διάφυσης κνήμης

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από τραύμα υψηλής ενέργειας στα οποία βλέπετε κάταγμα στη διάφυση της κνήμης.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] ακτινογραφίες κνήμης AP και πλάγια (συμπεριλαμβανομένων γόνατος και ποδοκνημικής).

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] κνήμη [εγγύς/μέσο/περιφερικό] τριτημόριο της διάφυσης: [εγκάρσιο/λοξό/σπειροειδές/συντριπτικό] κάταγμα· [.. mm] παρεκτόπιση και [πρόσθια/οπίσθια] γωνίωση. Περόνη [ακέραιη/με κάταγμα]. Αέρας στα μαλακά μόρια [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] κάταγμα διάφυσης κνήμης ([τύπος κατάγματος])· περόνη [ακέραιη/με κάταγμα]. Εάν υπάρχει αέρας στα μαλακά μόρια, συνιστάται κλινική συσχέτιση για ανοικτό κάταγμα.

028 Ακτινογραφία γόνατος · Οστεοαρθρίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Ασθενείς με χρόνιο πόνο στο γόνατο, χωρίς οξεία κάκωση.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] γόνατο [όρθια] Ακτινογραφίες AP και πλάγια.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] γόνατο: [έσω/έξω] στένωση του κνημομηριαίου μεσάρθριου διαστήματος, οριακά οστεόφυτα και υποχόνδρια σκλήρυνση. Δεν παρατηρείται οξύ κάταγμα.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] γόνατο: [με επικράτηση στο έσω διαμέρισμα] εκφυλιστικές αλλοιώσεις (οστεοαρθρίτιδα). Δεν διαπιστώνεται οξεία οστική παθολογία.

029 Ακτινογραφία αγκώνα (παιδί) · Υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά παιδιών με πόνο στον αγκώνα μετά από πτώση στα οποία βλέπετε σημείο λιπώδους επιθέματος ή γραμμή κατάγματος.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] ακτινογραφίες αγκώνα AP και πλάγια.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στην πλάγια λήψη το πρόσθιο λιπώδες επίθεμα είναι ανυψωμένο και το οπίσθιο λιπώδες επίθεμα διακρίνεται. Η πρόσθια βραχιόνια γραμμή σε σχέση με το κεφαλίδιο: [δεν διέρχεται από το μέσο τριτημόριο]. Στην υπερκονδύλια περιοχή [λεπτή/με παρεκτόπιση] γραμμή κατάγματος [παρατηρείται/δεν διακρίνεται σαφώς].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] υπερκονδύλιο κάταγμα βραχιονίου ([με παρεκτόπιση/χωρίς παρεκτόπιση]). Ακόμη και αν δεν διακρίνεται γραμμή κατάγματος, το σημείο του οπίσθιου λιπώδους επιθέματος είναι σημαντικό για αφανές κάταγμα· συνιστάται ορθοπαιδική εκτίμηση.

030 Ακτινογραφία · Κατάποση ακτινοσκιερού ξένου σώματος

Πότε χρησιμοποιείται: Ασθενείς, ιδίως παιδιά, με ιστορικό κατάποσης ξένου σώματος.

Τεχνική: Λήψη AP που περιλαμβάνει τράχηλο, θώρακα και κοιλία [± πλάγια] ακτινογραφία.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [άνω/μέσης/περιφερικής μοίρας οισοφάγου/στομάχου/λεπτού εντέρου] στην προβολή [.. mm] μεγέθους ακτινοσκιερό ξένο σώμα. Εικόνα διπλού δακτυλίου / διπλού περιγράμματος [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Δεν παρατηρείται ελεύθερος αέρας.

Συμπέρασμα: [Εντόπιση] στην προβολή: ακτινοσκιερό ξένο σώμα. Η εντόπιση στον οισοφάγο ή η υποψία μπαταρίας κουμπιού θεωρείται επείγουσα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα]. Τα ακτινοδιαυγαστικά ξένα σώματα ενδέχεται να μη φαίνονται στην ακτινογραφία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

Αξονική τομογραφία

35 πρότυπα: 4 φυσιολογικά, 31 συχνά ευρήματα της εφημερίας και της ρουτίνας.

031 Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά κεφαλαλγίας, συγκοπής ή ήπιας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης στα οποία δεν βλέπετε παθολογία.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· οι αξονικές τομές εκτιμήθηκαν σε εγκεφαλικό και οστικό παράθυρο.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται ενδοκρανιακή αιμορραγία, φαινόμενο μάζας ή παρεκτόπιση της μέσης γραμμής. Η διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας διατηρείται. Το κοιλιακό σύστημα και οι αύλακες έχουν εύρος ανάλογο της ηλικίας. Οι βασικές δεξαμενές είναι ανοικτές. Δεν παρατηρείται κάταγμα του θόλου του κρανίου. Οι απεικονιζόμενοι παραρρίνιοι κόλποι και οι μαστοειδείς κυψέλες είναι καλά αεριζόμενοι.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε οξεία ενδοκρανιακή παθολογία στην αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό. Το πρώιμο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να μη φαίνεται στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό· εάν η κλινική υποψία επιμένει, μπορεί να εξεταστεί μαγνητική με DWI.

032 Αξονική αυχενικής μοίρας (τραύμα) · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με ερώτημα οστικής κάκωσης αυχενικής μοίρας μετά από τραύμα στα οποία δεν βλέπετε παθολογία.

Τεχνική: Αξονική αυχενικής μοίρας χωρίς σκιαγραφικό· οβελιαίες και στεφανιαίες ανασυνθέσεις, οστικό παράθυρο και παράθυρο μαλακών μορίων.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Η ευθυγράμμιση των αυχενικών σπονδύλων διατηρείται. Δεν παρατηρείται οξύ κάταγμα ή εξάρθρημα. Οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις είναι σε αντιστοιχία. Η κρανιοαυχενική συμβολή είναι φυσιολογική. Το πάχος των προσπονδυλικών μαλακών μορίων είναι φυσιολογικό.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε οξεία τραυματική οστική παθολογία στην αξονική αυχενικής μοίρας. Η συνδεσμική κάκωση δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως με αξονική· εάν υπάρχουν νευρολογικά ευρήματα, συνιστάται μαγνητική τομογραφία.

033 Αξονική θώρακα · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Αξονικές θώρακα στις οποίες δεν βλέπετε παθολογία, σε ενδείξεις ρουτίνας ή μη ογκολογικές.

Τεχνική: [Με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό/Χωρίς σκιαγραφικό] αξονική τομογραφία θώρακος· αξιολόγηση σε μεσοθωρακικό και πνευμονικό παράθυρο.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν παρατηρούνται λεμφαδένες παθολογικού μεγέθους στο μεσοθωράκιο. Το μέγεθος της καρδιάς είναι φυσιολογικό, χωρίς περικαρδιακή συλλογή. Τα μεγάλα αγγεία έχουν φυσιολογικό εύρος. Δεν διαπιστώνεται πύκνωση, μάζα ή σημαντικός όζος στο πνευμονικό παρέγχυμα. Δεν υπάρχει πλευριτική συλλογή ή πνευμοθώρακας. Δεν παρατηρείται παθολογία στην απεικονιζόμενη άνω κοιλία και στα οστά.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε σημαντική παθολογία στην αξονική θώρακα.

034 Αξονική κοιλίας-πυέλου · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Αξονικές κοιλίας-πυέλου με σκιαγραφικό στις οποίες δεν βλέπετε οξεία παθολογία σε κοιλιακό άλγος.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας-πυέλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, πυλαία φλεβική φάση. Από του στόματος σκιαγραφικό [χορηγήθηκε/δεν χορηγήθηκε].

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ήπαρ, σπλήνας, πάγκρεας, επινεφρίδια και νεφροί φυσιολογικού μεγέθους και πυκνότητας· δεν διαπιστώνεται εστιακή βλάβη. Χοληδόχος κύστη φυσιολογική· τα ενδοηπατικά και εξωηπατικά χοληφόρα δεν είναι διατεταμένα. Δεν παρατηρείται διάταση ή πάχυνση τοιχώματος των εντερικών ελίκων. Σκωληκοειδής απόφυση [φυσιολογικής εμφάνισης/δεν διακρίνεται σαφώς, χωρίς ευρήματα φλεγμονής στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο]. Δεν υπάρχει ελεύθερο υγρό ή ελεύθερος αέρας. Δεν υπάρχουν λεμφαδένες παθολογικού μεγέθους. Η ουροδόχος κύστη είναι φυσιολογική. Δεν παρατηρούνται λυτικές ή οστεοβλαστικές βλάβες στα οστά.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε οξεία παθολογία στην αξονική κοιλίας-πυέλου.

035 Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · Επισκληρίδιο αιμάτωμα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση στα οποία βλέπετε αμφίκυρτη υπέρπυκνη συλλογή. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· εγκεφαλικό και οστικό παράθυρο.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [κροταφική/βρεγματική/μετωπιαία] περιοχή: χωρίς υπέρβαση των ραφών, αμφίκυρτου (φακοειδούς) σχήματος, στο μεγαλύτερο πάχος [.. mm] υπέρπυκνη εξωαξονική συλλογή. Στο παρακείμενο κρανίο [γραμμοειδής γραμμή κατάγματος]. Μετατόπιση μέσης γραμμής [.. mm]. Βασικές δεξαμενές [ανοικτές/εξαλειμμένες].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [περιοχή] οξύ επισκληρίδιο αιμάτωμα· [.. mm] παρεκτόπιση της μέσης γραμμής. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

036 Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · Υποσκληρίδιο αιμάτωμα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε μηνοειδή εξωαξονική συλλογή, ιδίως σε ηλικιωμένους και ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] κατά μήκος της κυρτότητας του ημισφαιρίου, με υπέρβαση των ραφών, μηνοειδούς σχήματος, [υπέρπυκνη/ισόπυκνη/υπόπυκνη/μικτής πυκνότητας] υποσκληρίδια συλλογή· μέγιστο πάχος [.. mm]. Εξάλειψη των αυλάκων, συμπίεση της ομόπλευρης πλάγιας κοιλίας και [.. mm] παρεκτόπιση της μέσης γραμμής.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [οξύ/υποξύ/χρόνιο/οξύ επί χρόνιου] υποσκληρίδιο αιμάτωμα· φαινόμενο μάζας [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

037 Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά αιφνίδιας έντονης κεφαλαλγίας ή μετατραυματικά, στα οποία βλέπετε υπερπυκνότητα στις δεξαμενές.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Βασικές δεξαμενές/σχισμές του Sylvius/μεσοημισφαιρική σχισμή/φλοιώδεις αύλακες] υπέρπυκνη υπαραχνοειδής αιμορραγία. Ενδοκοιλιακή αιμορραγία [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Διάταση κοιλιών [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Διάχυτη/Εστιακή] υπαραχνοειδής αιμορραγία. Υδροκέφαλος [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Εάν δεν υπάρχει ιστορικό τραύματος, συνιστάται αξονική αγγειογραφία για ανεύρυσμα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

038 Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · Ενδοεγκεφαλική αιμορραγία

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά ασθενών με οξύ νευρολογικό έλλειμμα στα οποία βλέπετε υπέρπυκνο ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [βασικών γαγγλίων/θαλάμου/λοβαίας/παρεγκεφαλιδικής] εντόπιση, [.. x .. mm] μεγέθους υπέρπυκνο παρεγχυματικό αιμάτωμα· περιφερικά υπόπυκνο οίδημα. Διάνοιξη στις κοιλίες [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Μετατόπιση μέσης γραμμής [.. mm].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [εντόπιση] οξύ ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα. Συνιστάται περαιτέρω διερεύνηση για την υποκείμενη αιτία ανάλογα με την κλινική εικόνα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

039 Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · Πρώιμα ευρήματα ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Πότε χρησιμοποιείται: Αξονικές που διενεργούνται στο πρωτόκολλο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου για οξύ εστιακό νευρολογικό έλλειμμα.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· έγινε πρόσθετη εκτίμηση με παράθυρο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [στην περιοχή αιμάτωσης της MCA/στον φλοιό της νήσου/στον φακοειδή πυρήνα] εξάλειψη της διαφοροποίησης φαιάς-λευκής ουσίας και ήπια υποπυκνότητα· εξάλειψη των παρακείμενων αυλάκων. Δεν παρατηρείται ενδοκρανιακή αιμορραγία.
Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [MCA] αγγειακή περιοχή: ευρήματα συμβατά με πρώιμη οξεία ισχαιμία· χωρίς ενδοκρανιακή αιμορραγία. Στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

040 Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · Σημείο υπέρπυκνης MCA

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με υποψία αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, όπου βλέπετε εμφανή υπερπυκνότητα στη MCA σε σχέση με την αντίθετη πλευρά.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] MCA [M1/M2] τμήμα: εμφανής υπερπυκνότητα σε σχέση με την αντίθετη πλευρά (σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας). Συνοδές πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Δεν παρατηρείται αιμορραγία.
Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] Σημείο υπέρπυκνης αρτηρίας στη MCA· πιθανώς ενδεικτικό οξέος θρόμβου. Συνιστάται εκτίμηση με αξονική αγγειογραφία. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

041 Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό · Υδροκέφαλος

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία οι κοιλίες είναι δυσανάλογα διευρυσμένες σε σχέση με τις αύλακες.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: Στις πλάγιες και την τρίτη κοιλία [και στην τέταρτη κοιλία] εμφανής διάταση δυσανάλογη προς τις αύλακες. Περικοιλιακή υποπυκνότητα [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Επίπεδο απόφραξης: [επίπεδο/δεν διακρίνεται σαφώς].
Συμπέρασμα: [Αποφρακτικός/Επικοινωνών] ευρήματα υπέρ υδροκεφάλου. Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση [αύξηση/χωρίς μεταβολή]. Εάν η εγκατάσταση είναι οξεία, η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

042 Αξονική εγκεφάλου · Μάζα και αγγειογενές οίδημα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά κεφαλαλγίας, επιληπτικών κρίσεων ή εστιακού ελλείμματος στα οποία βλέπετε βλάβη με φαινόμενο μάζας.

Τεχνική: Χωρίς σκιαγραφικό [± με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό] αξονική τομογραφία εγκεφάλου.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός]: [.. mm] μεγέθους [ισόπυκνη/υπέρπυκνη] χωροκατακτητική βλάβη· περιφερικά αγγειογενές οίδημα με δακτυλοειδείς προεκβολές. Φαινόμενο μάζας: εξάλειψη αυλάκων, [συμπίεση της ομόπλευρης κοιλίας], [.. mm] παρεκτόπιση της μέσης γραμμής.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] χωροκατακτητική βλάβη και περιβάλλον αγγειογενές οίδημα. Για χαρακτηρισμό συνιστάται μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου με σκιαγραφικό. Ευρήματα εγκολεασμού [δεν υπάρχουν/υπάρχουν· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε].

043 Αξονική εγκεφάλου · Κάταγμα θόλου του κρανίου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης στα οποία βλέπετε γραμμή κατάγματος στο οστικό παράθυρο.

Τεχνική: Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό· οστικό παράθυρο και 3D ανασύνθεση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [μετωπιαίο/βρεγματικό/κροταφικό/ινιακό] οστό: [γραμμοειδές/εμπιεστικό] γραμμή κατάγματος· βαθμός εμβύθισης [.. mm]. Παρακείμενη εξωαξονική αιμορραγία [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Πνευμοεγκέφαλος [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Αιμάτωμα τριχωτού της κεφαλής.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [οστό] [γραμμοειδές/εμπιεστικό] κάταγμα. Συνοδός ενδοκρανιακή αιμορραγία [δεν παρατηρείται/...].

044 Αξονική πνευμονική αγγειογραφία · Πνευμονική εμβολή

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε έλλειμμα πλήρωσης σε αξονική πνευμονική αγγειογραφία για υποψία πνευμονικής εμβολής. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Αξονική πνευμονική αγγειογραφία. Σκιαγράφηση πνευμονικής αρτηρίας [επαρκής/ανεπαρκής].

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά/Αμφοτερόπλευρα] [κύριες/λοβαίες/τμηματικές/υποτμηματικές] πνευμονικές αρτηρίες: ελλείμματα πλήρωσης. Λόγος δεξιάς/αριστερής κοιλίας [αυξημένος/φυσιολογικός]· στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα [επιπέδωση/κύρτωση προς τα αριστερά]· [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Σφηνοειδής περιφερική πύκνωση [δεν υπάρχει/υπάρχει· μπορεί να είναι συμβατή με έμφρακτο].

Συμπέρασμα: [Αμφοτερόπλευρη] οξεία πνευμονική θρομβοεμβολή. Ευρήματα υπερφόρτωσης δεξιάς κοιλίας [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

045 Αξονική θώρακα · Τυχαίος πνευμονικός όζος

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε τυχαίο όζο σε αξονική που έγινε για άλλο λόγο.

Τεχνική: [Με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό/Χωρίς σκιαγραφικό] αξονική τομογραφία θώρακος, λεπτές τομές.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] [τμήμα]: [.. mm] μεγέθους [συμπαγής/ημισυμπαγής/θαμβής υάλου] όζος· [ομαλό/λοβωτό/ακιδωτό] περίγραμμα. Επασβέστωση [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός]: [.. mm] [συμπαγής] όζος. Η ανάγκη και το διάστημα παρακολούθησης πρέπει να καθοριστούν μαζί με την κλινική ομάδα, με βάση το προφίλ κινδύνου του ασθενούς και τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες που έχει υιοθετήσει το ίδρυμά σας.

046 Αξονική θώρακα · Εμφύσημα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά καπνιστών ή ασθενών με ΧΑΠ στα οποία βλέπετε περιοχές εμφυσήματος.

Τεχνική: Αξονική θώρακα χωρίς σκιαγραφικό· πνευμονικό παράθυρο.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: Αμφοτερόπλευρα [με επικράτηση στους άνω λοβούς] [κεντρολοβιακό/παραδιαφραγματικό/πανλοβιακό] εμφύσημα κατά περιοχές. [Πομφόλυγες.] Δεν παρατηρείται πύκνωση ή μάζα.

Συμπέρασμα: [Κεντρολοβιδιακό] εμφύσημα. Δεν παρατηρείται οξεία παρεγχυματική παθολογία.

047 Αξονική θώρακα · Πυκνώσεις θολής υάλου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά δύσπνοιας, πυρετού ή υποξαιμίας στα οποία βλέπετε περιοχές θολής υάλου.

Τεχνική: [Χωρίς σκιαγραφικό/Με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό] αξονική τομογραφία θώρακος· πνευμονικό παράθυρο.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: Αμφοτερόπλευρα [περιφερικές/κεντρικές/διάχυτες], [με επικράτηση στους κάτω λοβούς] θολώσεις τύπου θαμβής υάλου. Πάχυνση μεσολοβιακών διαφραγμάτων [συνυπάρχει (εικόνα λιθόστρωτου)/δεν συνυπάρχει]. Πλευριτική συλλογή [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Αμφοτερόπλευρες πυκνώσεις θολής υάλου. Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει ιογενείς και άτυπες λοιμώξεις, πνευμονικό οίδημα, κυψελιδική αιμορραγία και άλλες φλεγμονώδεις διεργασίες· συνιστάται κλινική και εργαστηριακή συσχέτιση.

048 Αξονική θώρακα · Πνευμοθώρακας

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από τραύμα ή επέμβαση στα οποία βλέπετε αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα στην αξονική.

Τεχνική: Αξονική θώρακα· πνευμονικό παράθυρο.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] ημιθωράκιο: [πρόσθια/κορυφαία/διάχυτη] εντόπιση, στο μεγαλύτερο πάχος [.. mm] πνευμοθώρακας. Παρεκτόπιση μεσοθωρακίου [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Πνευμομεσοθωράκιο [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Υποδόριο εμφύσημα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Κατάγματα πλευρών [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [μικρός/μέτριος/μεγάλος] πνευμοθώρακας. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

049 Αξονική αγγειογραφία · Διαχωρισμός αορτής

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά αιφνίδιου θωρακικού πόνου ή πόνου στην πλάτη στα οποία βλέπετε κρημνό του έσω χιτώνα. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Αξονική χωρίς σκιαγραφικό και αξονική αγγειογραφία σε αρτηριακή φάση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Από την ανιούσα αορτή/περιφερικά της αριστερής υποκλειδίου αρτηρίας] και εκτείνεται έως [επίπεδο] επίπεδο: διαχωριστικός κρημνός έσω χιτώνα· αναγνωρίζονται αληθής και ψευδής αυλός. Επέκταση του διαχωρισμού [στους κλάδους του αορτικού τόξου/στην κοιλιακή αρτηρία/στην άνω μεσεντέριο αρτηρία/στις νεφρικές αρτηρίες] επέκταση: [λεπτομέρειες]. Περικαρδιακή συλλογή [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Αιμάτωμα μεσοθωρακίου [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Με συμμετοχή της ανιούσας αορτής (Stanford A)/χωρίς συμμετοχή της ανιούσας αορτής (Stanford B)] διαχωρισμός αορτής. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

050 Αξονική κοιλίας · Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε διάταση της αορτής σε κοιλιακό ή οσφυϊκό πόνο ή ως τυχαίο εύρημα.

Τεχνική: [Αξονική αγγειογραφία με σκιαγραφικό/αξονική κοιλίας σε πυλαία φλεβική φάση].

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στην υπονεφρική κοιλιακή αορτή, μέγιστης [.. mm] διαμέτρου [ατρακτοειδής/σακκοειδής] ανευρυσματική διάταση· επασβεστώσεις τοιχώματος και [τοιχωματικός θρόμβος]. Απόσταση από τις νεφρικές αρτηρίες [.. mm]. Περιαορτικό αιμάτωμα ή διήθηση του λιπώδους ιστού [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε].

Συμπέρασμα: Ανεύρυσμα υπονεφρικής κοιλιακής αορτής, μέγιστη διάμετρος [.. mm]. Ευρήματα ρήξης [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε]. Εάν υπάρχουν ευρήματα ρήξης, ως επείγον εύρημα, η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

051 Αξονική κοιλίας · Οξεία σκωληκοειδίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο στα οποία βλέπετε φλεγμαίνουσα σκωληκοειδή απόφυση.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας-πυέλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, πυλαία φλεβική φάση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Σκωληκοειδής απόφυση [.. mm] διαμέτρου, με παχυσμένο τοίχωμα και αυξημένη ενίσχυση· διήθηση του περιβάλλοντος λίπους. Κοπρόλιθος σκωληκοειδούς [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Περισκωληκοειδικό υγρό, απόστημα ή ελεύθερος αέρας [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Ευρήματα συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα. Ευρήματα διάτρησης ή αποστήματος [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε]. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

052 Αξονική κοιλίας · Οξεία εκκολπωματίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου στο αριστερό κάτω τεταρτημόριο στα οποία βλέπετε φλεγμονή σε τμήμα με εκκολπώματα.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας-πυέλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Σιγμοειδές/Κατιόν] κόλον: εκκολπώματα· [.. cm] μήκους τμήμα με πάχυνση τοιχώματος και διήθηση του περικολικού λίπους. Περικολικός ελεύθερος αέρας [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Απόστημα [δεν υπάρχει/υπάρχει, .. mm].

Συμπέρασμα: [Σιγμοειδές] κόλον: οξεία [μη επιπεπλεγμένη/επιπεπλεγμένη] εκκολπωματίτιδα. Η αξιολόγηση του παχέος εντέρου μετά την οξεία φάση αφήνεται στην κλινική κρίση.

053 Αξονική κοιλίας · Απόφραξη λεπτού εντέρου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με υποψία απόφραξης στην ακτινογραφία ή με εμέτους και διάταση.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας-πυέλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου με συμπεπτωκυίες έλικες περιφερικότερα· ζώνη μετάβασης [δεξιό κάτω τεταρτημόριο/πύελος/...]. Πιθανή αιτία: [συμφύσεις/κήλη/μάζα/δεν διακρίνεται σαφώς]. Μειωμένη ενίσχυση του εντερικού τοιχώματος, μεσεντέριο οίδημα και ελεύθερο υγρό [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Πνευμάτωση [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Περιοχή]: απόφραξη λεπτού εντέρου μηχανικού τύπου με ζώνη μετάβασης· πιθανή αιτία [αιτία]. Ευρήματα ισχαιμίας [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε]. Εάν υπάρχουν ευρήματα ισχαιμίας, ως επείγον εύρημα, η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

054 Αξονική κοιλίας · Πνευμοπεριτόναιο (διάτρηση)

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά οξείας κοιλίας στα οποία βλέπετε ελεύθερο αέρα στην αξονική. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας-πυέλου με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό· πρόσθετη εκτίμηση σε πνευμονικό παράθυρο.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Προηπατικά/περιπυλαία/εντός του μεσεντερίου] ελεύθερος αέρας. Ελεύθερο υγρό [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Πιθανή θέση διάτρησης: [στόμαχος/δωδεκαδάκτυλο/παχύ έντερο]· [έλλειμμα τοιχώματος/εστιακή πάχυνση τοιχώματος/περιφερική φλεγμονή].

Συμπέρασμα: Πνευμοπεριτόναιο· [πιθανή εντόπιση]: ευρήματα υπέρ διάτρησης. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

055 Αξονική χωρίς σκιαγραφικό · Λίθος ουρητήρα

Πότε χρησιμοποιείται: Αξονικές με πρωτόκολλο λιθίασης σε υποψία κωλικού νεφρού.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας-πυέλου χωρίς σκιαγραφικό (πρωτόκολλο λιθίασης).

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] ουρητήρας [στο εγγύς/μέσο/περιφερικό τμήμα/στην κυστεοουρητηρική συμβολή] [.. mm] λίθος. Στον εγγύς ουρητήρα και στο αποχετευτικό σύστημα [ήπια/μέτρια/έντονη] διάταση· διήθηση του περινεφρικού λίπους. Ετερόπλευρος νεφρός: [χωρίς λίθο/λίθος .. mm].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [περιφερικό] ουρητήρας: [.. mm] λίθος και [ήπια] υδρουρητηρονέφρωση.

056 Αξονική κοιλίας · Οξεία παγκρεατίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με κλινική και εργαστηριακή υποψία παγκρεατίτιδας, στα οποία ζητείται εκτίμηση επιπλοκών.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, [παγκρεατική φάση και] πυλαία φλεβική φάση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Πάγκρεας [διάχυτα/εστιακά] οιδηματώδες· διήθηση και υγρό στο περιπαγκρεατικό λίπος. Μη ενισχυόμενη περιοχή στο παρέγχυμα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Λίθοι χοληδόχου κύστης [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Σπληνική και πυλαία φλέβα [βατές/υποψία θρόμβωσης].

Συμπέρασμα: Οξεία [διάμεση οιδηματώδης/νεκρωτική] παγκρεατίτιδα. Επιπλοκές: [καμία/...].

057 Αξονική κοιλίας · Πολλαπλές ηπατικές βλάβες ενδεικτικές μεταστάσεων

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά ογκολογικών ασθενών ή πρώτης ανεύρεσης, στα οποία βλέπετε πολλαπλές βλάβες στο ήπαρ.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, πυλαία φλεβική φάση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Και στους δύο λοβούς του ήπατος, η μεγαλύτερη στο τμήμα [..]: [.. mm] μεγέθους, πολλαπλές υπόπυκνες βλάβες με περιφερική ενίσχυση.

Συμπέρασμα: Πολλαπλές ηπατικές βλάβες πιθανώς συμβατές με μεταστάσεις. Σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση: [νέες/αυξημένες/σταθερές]. Συνιστάται κλινική και, εφόσον χρειάζεται, ιστοπαθολογική συσχέτιση.

058 Αξονική τραύματος · Κάκωση σπληνός

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά αμβλείας κοιλιακής κάκωσης στα οποία βλέπετε ρήξη ή αιμάτωμα σπληνός. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Αξονική τραύματος με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό, αρτηριακή και πυλαία φλεβική φάση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στον σπλήνα [.. mm] μήκους ρήξη / υποκαψική αιμάτωμα. Περισπληνικό και [πυελικό] ελεύθερο υγρό (συμβατό με αιμοπεριτόναιο). Ενεργός διαφυγή σκιαγραφικού [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Κάκωση σπληνός ([ρήξη/αιμάτωμα]) και αιμοπεριτόναιο. Ευρήματα ενεργού αιμορραγίας [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Η διαβάθμιση γίνεται σύμφωνα με το σύστημα που χρησιμοποιεί το ίδρυμά σας. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

059 Αξονική κοιλίας · Απλή κύστη ήπατος

Πότε χρησιμοποιείται: Τυχαίες κυστικές ηπατικές βλάβες με τυπική εμφάνιση.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ηπατικό τμήμα [..]: [.. mm] μεγέθους βλάβη με σαφή όρια, πυκνότητας υγρού, λεπτό τοίχωμα, χωρίς ενίσχυση.

Συμπέρασμα: Ηπατικό τμήμα [..]: βλάβη συμβατή με απλή κύστη.

060 Αξονική κοιλίας · Οξεία χολοκυστίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου στο δεξιό άνω τεταρτημόριο στα οποία βλέπετε φλεγμονή της χοληδόχου κύστης στην αξονική.

Τεχνική: Αξονική κοιλίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Χοληδόχος κύστη διατεταμένη, με παχυσμένο τοίχωμα· περιχολοκυστικό υγρό και διήθηση του λιπώδους ιστού. Στον αυλό [διακρίνεται λίθος/δεν διακρίνεται λίθος]. Αέρας στο τοίχωμα, απώλεια ενίσχυσης ή διάτρηση [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Ευρήματα ενδεικτικά οξείας χολοκυστίτιδας. Η ευαισθησία της αξονικής για χολολίθους είναι περιορισμένη· συνιστάται συσχέτιση με υπερηχογράφημα.

061 Αξονική σπονδυλικής στήλης · Οξύ κάταγμα σπονδύλου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά θωρακικού ή οσφυϊκού πόνου μετά από κάκωση στα οποία βλέπετε κάταγμα σπονδυλικού σώματος.

Τεχνική: Χωρίς σκιαγραφικό [θωρακοοσφυϊκής μοίρας] Αξονική τομογραφία· οβελιαίες και στεφανιαίες ανασυνθέσεις.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [L1] σπονδυλικό σώμα: [συμπιεστικό/εκρηκτικό] κάταγμα· απώλεια πρόσθιου ύψους. Οπίσθιο τοίχωμα [διατηρημένο/στένωση του σπονδυλικού σωλήνα από οπισθοπροωθημένο τεμάχιο]. Οπίσθια στοιχεία [ακέραια/με κάταγμα].

Συμπέρασμα: [L1] σπόνδυλος: οξείας εμφάνισης [συμπιεστικό/εκρηκτικό] κάταγμα· στον σπονδυλικό σωλήνα [στένωση: ναι/όχι]. Εάν υπάρχουν νευρολογικά ευρήματα, συνιστάται μαγνητική τομογραφία.

062 Αξονική παραρρινίων κόλπων · Παραρρινοκολπίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Αξονικές παραρρινίων κόλπων για χρόνια ή υποτροπιάζουσα παραρρινοκολπίτιδα.

Τεχνική: Αξονική παραρρινίων κόλπων χωρίς σκιαγραφικό· στεφανιαία ανασύνθεση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά/Αμφοτερόπλευρα] [γναθιαίο/ηθμοειδή/μετωπιαίο/σφηνοειδή] κόλπος: [πάχυνση βλεννογόνου/υδραερικό επίπεδο/πλήρης σκίαση]. Οστεομεατικό σύμπλεγμα [ανοικτό/κλειστό]. Δεν παρατηρείται οστική καταστροφή ούτε επέκταση στον οφθαλμικό κόγχο ή ενδοκρανιακά.

Συμπέρασμα: [Εντόπιση] ευρήματα συμβατά με ιγμορίτιδα (παραρρινοκολπίτιδα). Το επίπεδο αέρα-υγρού μπορεί να είναι συμβατό με οξεία παραρρινοκολπίτιδα· συνιστάται κλινική συσχέτιση.

063 Αξονική κοιλίας · Τυχαίος όζος επινεφριδίου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε τυχαίο όζο στο επινεφρίδιο σε αξονική που έγινε για άλλο λόγο.

Τεχνική: [Χωρίς σκιαγραφικό/Με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό] αξονική τομογραφία κοιλίας.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] επινεφρίδιο: [.. mm] μεγέθους όζος με σαφή όρια· [πυκνότητα χωρίς σκιαγραφικό .. HU/στην εξέταση με σκιαγραφικό δεν είναι δυνατός ο χαρακτηρισμός].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] όζος επινεφριδίου. Ο χαρακτηρισμός και η ανάγκη παρακολούθησης πρέπει να καθοριστούν μαζί με την κλινική ομάδα σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες· εφόσον χρειάζεται, συνιστάται αξονική τομογραφία με πρωτόκολλο επινεφριδίων ή μαγνητική τομογραφία χημικής μετατόπισης.

064 Αξονική θώρακα · Πνευμονία (πύκνωση)

Πότε χρησιμοποιείται: Αξονικές σε πνευμονίες που δεν είναι σαφείς στην ακτινογραφία ή με υποψία επιπλοκής.

Τεχνική: [Χωρίς σκιαγραφικό/Με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό] αξονική τομογραφία θώρακος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός]: πύκνωση με αεροβρογχογράμματα· περιφερικά θολώσεις τύπου θαμβής υάλου. Υπεζωκοτική συλλογή [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Στο μεσοθωράκιο [αντιδραστικής εμφάνισης] λεμφαδένες. Κοιλότητα ή απόστημα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] πύκνωση· μπορεί να είναι συμβατή με λοιμώδη διεργασία (πνευμονία). Ο έλεγχος μετά τη θεραπεία συνιστάται κατά την κλινική κρίση.

065 Αξονική τραύματος · Αιμοπεριτόναιο

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά αμβλείας κοιλιακής κάκωσης στα οποία βλέπετε ελεύθερο υγρό.

Τεχνική: Αξονική τραύματος με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Στον θύλακο του Morison/περισπληνικά/στην πύελο]: ελεύθερο υγρό· πυκνότητα [.. HU], συμβατό με αιμοπεριτόναιο. Κάκωση συμπαγών οργάνων [δεν παρατηρείται/...]. Τοίχωμα εντέρου και μεσεντέριο [δεν παρατηρείται παθολογία/...].

Συμπέρασμα: [Μικρή/Μέτρια/Μεγάλη] ποσότητα αιμοπεριτοναίου. Εάν δεν παρατηρείται κάκωση συμπαγούς οργάνου, συνιστάται κλινική παρακολούθηση για κάκωση εντέρου ή μεσεντερίου. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Μαγνητική τομογραφία

25 πρότυπα: 3 φυσιολογικά, 22 συχνά ευρήματα της ρουτίνας και της εφημερίας.

066 Μαγνητική εγκεφάλου · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Μαγνητικές εγκεφάλου στις οποίες δεν βλέπετε παθολογία, κατά τη διερεύνηση κεφαλαλγίας, ζάλης ή επιληπτικών κρίσεων.

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου· αξονικές T1, T2, FLAIR, DWI/ADC, [SWI/T2*], [T1 μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού] ακολουθίες.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν διαπιστώνεται διαταραχή σήματος στο εγκεφαλικό παρέγχυμα. Δεν υπάρχει περιορισμός διάχυσης στη DWI. Το κοιλιακό σύστημα και οι αύλακες είναι ανάλογοι της ηλικίας. Οι δομές της μέσης γραμμής είναι φυσιολογικές. [Δεν παρατηρείται παθολογική ενίσχυση μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.] Παρατηρούνται κενά σήματος ροής στις κύριες αρτηρίες.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε σημαντική παθολογία στη μαγνητική εγκεφάλου.

067 Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά οσφυαλγίας στα οποία δεν βλέπετε παθολογία δίσκου, ρίζας ή σπονδυλικού σωλήνα.

Τεχνική: Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας· οβελιαίες T1, T2, STIR και αξονικές T2 ακολουθίες.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Η οσφυϊκή λόρδωση διατηρείται, η σπονδυλική ευθυγράμμιση είναι φυσιολογική. Τα ύψη των σπονδυλικών σωμάτων και το σήμα του μυελού των οστών είναι φυσιολογικά. Δεν παρατηρείται σημαντική εκφύλιση ή κήλη των μεσοσπονδύλιων δίσκων. Ο σπονδυλικός σωλήνας και τα μεσοσπονδύλια τρήματα είναι ελεύθερα. Ο μυελικός κώνος σε φυσιολογικό επίπεδο και με φυσιολογικό σήμα.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε σημαντική παθολογία στη μαγνητική οσφυϊκής μοίρας.

068 Μαγνητική γόνατος · Φυσιολογική

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου ή κάκωσης γόνατος στα οποία δεν βλέπετε δομική παθολογία.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] μαγνητική τομογραφία γόνατος· ακολουθίες PD με καταστολή λίπους, T1 και T2, σε τρία επίπεδα.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται αύξηση σήματος ενδεικτική ρήξης στους μηνίσκους. Ο πρόσθιος και ο οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος, οι πλάγιοι σύνδεσμοι και ο εκτατικός μηχανισμός είναι φυσιολογικοί. Δεν υπάρχει οίδημα μυελού των οστών. Ο αρθρικός χόνδρος διατηρείται. Δεν υπάρχει σημαντική αρθρική συλλογή.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] γόνατο: στη μαγνητική τομογραφία δεν διαπιστώνεται σημαντική παθολογία.

069 Μαγνητική εγκεφάλου · Οξύ έμφρακτο (DWI)

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά οξέος εστιακού ελλείμματος στα οποία βλέπετε περιορισμό διάχυσης. Απαιτείται ενημέρωση.

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου· ακολουθίες DWI/ADC, FLAIR, T2, SWI/T2*.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [περιοχή]: περιοχή υπερέντονη στην DWI, υπόεντονη στον χάρτη ADC, με περιορισμό της διάχυσης. Στην FLAIR [χωρίς σαφή μεταβολή σήματος/ήπια υπερέντονο σήμα]. Αιμορραγική μετατροπή [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [αρτηρία] αγγειακή περιοχή: οξύ έμφρακτο. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

070 Μαγνητική εγκεφάλου · Απομυελινωτικές πλάκες

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά οπτικής νευρίτιδας, αισθητικού ελλείμματος ή παρακολούθησης σκλήρυνσης κατά πλάκας στα οποία βλέπετε βλάβες λευκής ουσίας.

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου· FLAIR (κατά προτίμηση 3D), T2, T1, DWI, T1 μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: Περικοιλιακές, [παραφλοιώδεις], [υποσκηνιδιακές] εντόπιση, ωοειδείς υπερέντονες βλάβες στις T2/FLAIR, προσανατολισμένες κάθετα στο μεσολόβιο. Μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού [ενίσχυση σε .. βλάβες/χωρίς ενίσχυση].

Συμπέρασμα: Βλάβες λευκής ουσίας πιθανώς συμβατές με απομυελινωτική νόσο. Νέες ή ενισχυόμενες βλάβες σε σχέση με την προηγούμενη εξέταση [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Η διάγνωση πρέπει να εκτιμάται μαζί με τα κλινικά ευρήματα και τα τρέχοντα διαγνωστικά κριτήρια.

071 Μαγνητική εγκεφάλου · Ενδοαξονική μάζα με δακτυλιοειδή ενίσχυση

Πότε χρησιμοποιείται: Ενισχυόμενες παρεγχυματικές βλάβες με φαινόμενο μάζας και οίδημα.

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου με σκιαγραφικό· DWI, [αιμάτωση], ακολουθίες SWI.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός]: [.. mm] μεγέθους μάζα με ανώμαλη δακτυλιοειδή ενίσχυση και κεντρική νέκρωση· περιφερικά αγγειογενές οίδημα και φαινόμενο μάζας. Επέκταση στο μεσολόβιο [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Έντονος περιορισμός διάχυσης στο κεντρικό τμήμα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [λοβός] ενδοαξονική μάζα με δακτυλιοειδή ενίσχυση· στη διαφορική διάγνωση πρωτίστως όγκος γλοίας υψηλού βαθμού κακοήθειας και μετάσταση. Εάν υπάρχει έντονος κεντρικός περιορισμός της διάχυσης, το απόστημα πρέπει να περιλαμβάνεται στη διαφορική διάγνωση.

072 Μαγνητική εγκεφάλου · Μηνιγγίωμα

Πότε χρησιμοποιείται: Εξωαξονικές μάζες με σκληρομηνιγγική βάση και ομοιογενή ενίσχυση.

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου με σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Περιοχή]: με βάση τη σκληρά μήνιγγα, [.. mm] μεγέθους, ισοέντονη στην T1, ομοιογενώς ενισχυόμενη εξωαξονική μάζα· σημείο σκληράς ουράς (dural tail). Οίδημα στο παρακείμενο παρέγχυμα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Φαινόμενο μάζας [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Περιοχή]: εξωαξονική μάζα συμβατή με μηνιγγίωμα.

073 Μαγνητική υπόφυσης · Αδένωμα υπόφυσης

Πότε χρησιμοποιείται: Μαγνητικές υπόφυσης λόγω ορμονικής διαταραχής ή απώλειας οπτικού πεδίου.

Τεχνική: Μαγνητική υπόφυσης· στεφανιαίες και οβελιαίες T1, T2 λεπτών τομών, δυναμικές σειρές με σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στον υποφυσιακό αδένα [.. mm] μεγέθους βλάβη με καθυστερημένη ενίσχυση σε σχέση με τον φυσιολογικό αδένα στις δυναμικές σειρές. Υπερεφιππιαία επέκταση [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]· πίεση στο οπτικό χίασμα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Διήθηση σηραγγώδους κόλπου [ύποπτη/δεν υπάρχει]. Μίσχος υπόφυσης [στη μέση γραμμή/παρεκτοπισμένος].

Συμπέρασμα: Υποφυσιακό [μικρο/μακρο]αδένωμα (συμβατή βλάβη). Συνιστάται ενδοκρινολογική συσχέτιση.

074 Μαγνητική εγκεφάλου · Απόστημα εγκεφάλου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με πυρετό και εστιακό έλλειμμα στα οποία βλέπετε δακτυλιοειδώς ενισχυόμενη βλάβη με ομαλό τοίχωμα. Απαιτείται ενημέρωση.

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου με σκιαγραφικό· συμπεριλαμβάνονται DWI/ADC.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Εντόπιση]: [.. mm] μεγέθους βλάβη με λεπτό και ομαλό τοίχωμα και δακτυλιοειδή ενίσχυση· το περιεχόμενό της παρουσιάζει έντονο περιορισμό της διάχυσης στην DWI. Περιβάλλον αγγειογενές οίδημα.

Συμπέρασμα: Ευρήματα συμβατά με απόστημα εγκεφάλου. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

075 Μαγνητική εγκεφάλου και μαγνητική φλεβογραφία · Θρόμβωση φλεβωδών κόλπων

Πότε χρησιμοποιείται: Ασθενείς με κεφαλαλγία, επιληπτικές κρίσεις ή οίδημα θηλής, ιδίως με παράγοντες κινδύνου. Απαιτείται ενημέρωση.

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου και μαγνητική φλεβογραφία με/χωρίς σκιαγραφικό.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Άνω οβελιαίος/εγκάρσιος/σιγμοειδής] κόλπος: απώλεια του φυσιολογικού κενού ροής και σήμα συμβατό με θρόμβο· στη φλεβογραφία MR έλλειμμα πλήρωσης/απώλεια ροής. Φλεβικό έμφρακτο ή αιμορραγία στο παρακείμενο παρέγχυμα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Κόλπος] θρόμβωση. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

076 Μαγνητική εγκεφάλου · Χρόνια νόσος μικρών αγγείων

Πότε χρησιμοποιείται: Μη ειδικές βλάβες λευκής ουσίας σε ηλικιωμένους ή ασθενείς με αγγειακούς παράγοντες κινδύνου.

Τεχνική: Μαγνητική εγκεφάλου· ακολουθίες FLAIR, T2, DWI.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Αμφοτερόπλευρες στικτές και κατά τόπους τείνουσες σε συρροή υπερέντονες εστίες σε T2/FLAIR στην περικοιλιακή και εν τω βάθει λευκή ουσία. Δεν υπάρχει περιορισμός διάχυσης στη DWI. [Χρόνια κενοτοπιώδη έμφρακτα.]

Συμπέρασμα: Αλλοιώσεις λευκής ουσίας πιθανώς συμβατές με χρόνια νόσο μικρών αγγείων. Δεν διαπιστώνεται οξύ έμφρακτο.

077 Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας · Κήλη μεσοσπονδύλιου δίσκου

Πότε χρησιμοποιείται: Μαγνητικές οσφυϊκής μοίρας για οσφυαλγία με αντανάκλαση στο σκέλος (ριζοπάθεια).

Τεχνική: Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας· οβελιαίες T1, T2 και αξονικές T2 ακολουθίες.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: L [4-5] δίσκος: απώλεια σήματος στην T2 και μείωση ύψους· [δεξιά/αριστερά] [παράμεση/τρηματική] [προβολή/εξώθηση] τύπου κήλη δίσκου. [Δεξιά/Αριστερά] [L5] νευρική ρίζα: [επαφή/πίεση]. Σπονδυλικός σωλήνας [ελεύθερος/στενωμένος]. Μεσοσπονδύλια τρήματα [ελεύθερος/στενωμένος].

Συμπέρασμα: L [4-5] [δεξιά παράμεση] μεσοσπονδύλιος δίσκος [εξώθηση]· [L5] νευρική ρίζα: [πίεση].

078 Μαγνητική αυχενικής μοίρας · Σύμπλεγμα δίσκου-οστεοφύτου

Πότε χρησιμοποιείται: Μαγνητικές αυχενικής μοίρας για πόνο στον αυχένα και στο άνω άκρο ή αιμωδία.

Τεχνική: Μαγνητική αυχενικής μοίρας· οβελιαίες T1, T2, STIR και αξονικές T2 ακολουθίες.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: C [5-6] επίπεδο [δεξιά/αριστερά] [παράμεση/τρηματική] σύμπλεγμα δίσκου-οστεοφύτου· [δεξιά/αριστερά] στένωση του νευρικού τρήματος. Σήμα νωτιαίου μυελού [φυσιολογικό/υπερέντονο σε T2].

Συμπέρασμα: C [5-6] σύμπλεγμα δίσκου-οστεοφύτου και [δεξιά] στένωση τρήματος. Μεταβολή σήματος στον νωτιαίο μυελό [δεν υπάρχει/υπάρχει· μπορεί να είναι συμβατή με μυελοπάθεια].

079 Μαγνητική θωρακικής μοίρας · Επισκληρίδια πίεση και πίεση νωτιαίου μυελού

Πότε χρησιμοποιείται: Ασθενής με γνωστή κακοήθεια και πόνο στην πλάτη ή νέο νευρολογικό έλλειμμα. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Μαγνητική τομογραφία με σκιαγραφικό: θωρακική μοίρα [και ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης] (MT).

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: T [..] σπόνδυλος: υπόεντονη στην T1, ενισχυόμενη βλάβη μυελού των οστών· επισκληρίδια επέκταση με στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και πίεση του νωτιαίου μυελού. Αύξηση σήματος T2 στον μυελό [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Σε άλλα επίπεδα [χωρίς πρόσθετες βλάβες/πρόσθετες βλάβες].

Συμπέρασμα: T [..] επίπεδο: βλάβη πιθανώς συμβατή με επισκληρίδια επέκταση όγκου και πίεση του νωτιαίου μυελού. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

080 Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας · Οξύ συμπιεστικό κάταγμα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά οσφυαλγίας μετά από ήπια κάκωση ή χωρίς κάκωση στα οποία βλέπετε απώλεια ύψους σπονδυλικού σώματος.

Τεχνική: Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας· οβελιαίες ακολουθίες T1, T2, STIR.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [L1] σώμα: απώλεια ύψους· οίδημα μυελού των οστών στην STIR. Οπίσθια προβολή (retropulsion) του οπίσθιου τοιχώματος [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Συμμετοχή οπίσθιων στοιχείων, επισκληρίδια ή παρασπονδυλική μάζα μαλακών μορίων [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε].

Συμπέρασμα: [L1] σπόνδυλος: [οξύ/υποξύ] συμπιεστικό κάταγμα. Ευρήματα υπέρ παθολογικού κατάγματος [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε· συνιστάται περαιτέρω εκτίμηση].

081 Μαγνητική γόνατος · Ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από στροφική κάκωση με αστάθεια και αρθρική συλλογή.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] μαγνητική τομογραφία γόνατος· ακολουθίες PD με καταστολή λίπους και T1, σε τρία επίπεδα.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: ΠΧΣ: [εγγύς/μέσο τμήμα] λύση της συνέχειας και απώλεια της φυσιολογικής γραμμοειδούς εικόνας. Θλάση οστού στον έξω μηριαίο κόνδυλο και στο οπισθοπλάγιο κνημιαίο πλατό [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Αρθρική συλλογή.

Συμπέρασμα: [Ολικού πάχους/Μερικού πάχους] ρήξη ΠΧΣ. Συνοδός [μηνίσκος/πλάγιος σύνδεσμος] παθολογία [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

082 Μαγνητική γόνατος · Ρήξη μηνίσκου

Πότε χρησιμοποιείται: Μαγνητικές γόνατος για εμπλοκή, πόνο στη μεσάρθρια γραμμή ή μετά από κάκωση.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] μαγνητική τομογραφία γόνατος· ακολουθίες PD με καταστολή λίπους.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Έσω/Έξω] μηνίσκος [οπίσθιο κέρας/σώμα/πρόσθιο κέρας] μοίρα: προς την αρθρική επιφάνεια [οριζόντια/λοξή/ακτινωτή/επιμήκης] αύξηση σήματος.
[Δεν παρατηρείται/Παρατηρείται μετατοπισμένο τμήμα μηνίσκου (λαβή κάδου).]

Συμπέρασμα: [Έσω] μηνίσκος [οπίσθιο κέρας] [λοξή] ρήξη.

083 Μαγνητική γόνατος · Οστική θλάση

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με φυσιολογική ακτινογραφία μετά από κάκωση στα οποία βλέπετε οίδημα μυελού των οστών στη μαγνητική.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] μαγνητική τομογραφία γόνατος· ακολουθίες PD με καταστολή λίπους και T1.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Έξω μηριαίος κόνδυλος/κνημιαίο πλατό]: οίδημα μυελού των οστών στις ακολουθίες με καταστολή λίπους, χωρίς εμφανή γραμμή κατάγματος. Γραμμοειδής υπόεντονη γραμμή κατάγματος στην T1 [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Περιοχή]: θλάση οστού·
[δεν παρατηρείται γραμμή κατάγματος/παρατηρείται υποχόνδρια γραμμή κατάγματος].

084 Μαγνητική ώμου · Ρήξη στροφικού πετάλου

Πότε χρησιμοποιείται: Μαγνητικές ώμου για πόνο στον ώμο και αδυναμία απαγωγής.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] μαγνητική τομογραφία ώμου· ακολουθίες PD/T2 με καταστολή λίπους και T1.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Τένοντας υπερακανθίου: στο [πρόσθιο] μοίρα [μερικού πάχους αρθρικής επιφάνειας/μερικού πάχους θυλακικής επιφάνειας/ολικού πάχους] ρήξη· απόσυρση [.. mm]. Ατροφία ή λιπώδης διήθηση μυός [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Υγρό στον υπακρωμιακό-υποδελτοειδή θύλακο.

Συμπέρασμα: Στον τένοντα του υπερακανθίου [ολικού πάχους/μερικού πάχους] ρήξη· απόσυρση [.. mm].

085 Μαγνητική ισχίου · Άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής

Πότε χρησιμοποιείται: Ασθενείς με πόνο στο ισχίο, λήψη κορτικοστεροειδών ή άλλους παράγοντες κινδύνου.

Τεχνική: Μαγνητική αμφοτέρων των ισχίων· στεφανιαίες T1, STIR και αξονικές ακολουθίες.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] μηριαία κεφαλή: υποχόνδρια περιοχή σαν χάρτη, περιβαλλόμενη από υπόεντονη γραμμή στην T1· σημείο διπλής γραμμής στην T2. Κατάρρευση αρθρικής επιφάνειας [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Αρθρική συλλογή [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Ετερόπλευρη μηριαία κεφαλή [φυσιολογική/παρόμοια αλλοίωση].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] άσηπτη νέκρωση μηριαίας κεφαλής· κατάρρευση αρθρικής επιφάνειας [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε].

086 Μαγνητική ήπατος · Αιμαγγείωμα

Πότε χρησιμοποιείται: Χαρακτηρισμός ηπατικής βλάβης που παρέμεινε ασαφής στο υπερηχογράφημα ή στην αξονική.

Τεχνική: Δυναμική μαγνητική ήπατος με σκιαγραφικό· T2, DWI και αρτηριακή, πυλαία φλεβική και καθυστερημένη φάση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ηπατικό τμήμα [..]: [.. mm], βλάβη έντονα υπερέντονη στις T2, με περιφερική οζώδη και κεντρομόλο προϊούσα ενίσχυση στις δυναμικές σειρές.

Συμπέρασμα: Ηπατικό τμήμα [..]: βλάβη συμβατή με τυπικό αιμαγγείωμα.

087 MRCP · Χοληδοχολιθίαση

Πότε χρησιμοποιείται: Εκτίμηση των χοληφόρων σε ασθενή με ευρήματα χολόστασης ή χολολίθους.

Τεχνική: MRCP· έντονα T2-σταθμισμένες 2D και 3D ακολουθίες.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στο περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου [.. mm] μεγέθους έλλειμμα πλήρωσης που προκαλεί κενό σήματος στην T2. Χοληδόχος πόρος [.. mm] διαμέτρου· στα ενδοηπατικά χοληφόρα [ήπια] διάταση. Χοληδόχος κύστη: [λίθοι].

Συμπέρασμα: Λίθος στο περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου (χοληδοχολιθίαση) και διάταση των χοληφόρων. Εάν υπάρχει κλινική υποψία χολαγγειίτιδας, η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

088 Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας · Σπονδυλοδισκίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Μαγνητικές με σκιαγραφικό σε ασθενείς με πυρετό, αυξημένους δείκτες φλεγμονής και οσφυαλγία.

Τεχνική: Μαγνητική οσφυϊκής μοίρας με σκιαγραφικό· T1, T2, STIR και T1 με καταστολή λίπους μετά τη χορήγηση σκιαγραφικού.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ι[..] δίσκος: υπερένταση στην T2 και ενίσχυση· διαβρώσεις των παρακείμενων τελικών πλακών και οίδημα μυελού των οστών. [Παρασπονδυλική/επισκληρίδια] [φλέγμονας/απόστημα] [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Ι[..] ευρήματα συμβατά με σπονδυλοδισκίτιδα· επισκληρίδιο απόστημα [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Εάν υπάρχει επισκληρίδιο απόστημα, η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

089 Μαγνητική γόνατος · Ιγνυακή κύστη (Baker)

Πότε χρησιμοποιείται: Ασθενείς με διόγκωση ή πόνο στην οπίσθια επιφάνεια του γόνατος.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] μαγνητική τομογραφία γόνατος.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στον ιγνυακό βόθρο, μεταξύ της έσω κεφαλής του γαστροκνημίου και του τένοντα του ημιυμενώδους, εκτείνεται [.. mm] συλλογή υγρού. Περιβάλλον οίδημα υπέρ ρήξης [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Ιγνυακή κύστη (Baker)· ευρήματα ρήξης [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

090 Μαγνητική πυέλου · Απλή κύστη εξαρτήματος

Πότε χρησιμοποιείται: Χαρακτηρισμός κυστικής βλάβης εξαρτήματος που ανιχνεύθηκε στο υπερηχογράφημα.

Τεχνική: Μαγνητική πυέλου με σκιαγραφικό· T1, T1 με καταστολή λίπους, T2, DWI.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] ωοθήκη: [.. mm] μεγέθους κυστική βλάβη με λεπτό και ομαλό τοίχωμα, ομοιογενώς υπερέντονη στην T2, χωρίς συμπαγές στοιχείο ή ενισχυόμενα διαφραγμάτια.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] ωοθήκη: βλάβη συμβατή με απλή κύστη. Η ανάγκη παρακολούθησης πρέπει να καθοριστεί από την κλινική ομάδα ανάλογα με την ηλικία της ασθενούς και την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

Υπερηχογράφημα και Doppler

30 πρότυπα: 5 φυσιολογικά, 25 συχνά ευρήματα της εφημερίας και της ρουτίνας (συμπεριλαμβάνονται POCUS και eFAST).

091 Υπερηχογράφημα όλης της κοιλίας · Φυσιολογικό

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Υπερηχογραφήματα κοιλίας στα οποία δεν βλέπετε παθολογία, σε κοιλιακό άλγος ή έλεγχο ρουτίνας.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα όλης της κοιλίας· [σε κατάσταση νηστείας].

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ήπαρ φυσιολογικού μεγέθους και ηχογένειας, χωρίς εστιακή βλάβη. Χοληδόχος κύστη με φυσιολογικό τοίχωμα και άνηχο αυλό· δεν παρατηρούνται λίθοι. Τα ενδοηπατικά και εξωηπατικά χοληφόρα δεν είναι διατεταμένα. Πάγκρεας [ορατά τμήματα] χωρίς ιδιαιτερότητες. Σπλήνας φυσιολογικού μεγέθους. Αμφότεροι οι νεφροί φυσιολογικού μεγέθους και ηχογένειας παρεγχύματος· το πυελοκαλυκικό σύστημα δεν είναι διατεταμένο. Ουροδόχος κύστη [πλήρης, με φυσιολογικό τοίχωμα]. Δεν παρατηρείται ελεύθερο ενδοκοιλιακό υγρό.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε παθολογία στο υπερηχογράφημα όλης της κοιλίας.

092 Υπερηχογράφημα ουροποιητικού · Φυσιολογικό

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου στη λαγόνα, ουρολοίμωξης ή νεφρικής δυσλειτουργίας στα οποία δεν βλέπετε παθολογία.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα ουροποιητικού.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Αμφότεροι οι νεφροί φυσιολογικού μεγέθους, θέσης και πάχους παρεγχύματος· η φλοιομυελική διαφοροποίηση διατηρείται. Το πυελοκαλυκικό σύστημα δεν είναι διατεταμένο. Δεν παρατηρούνται λίθοι ή μάζα. Ουροδόχος κύστη [πλήρης, με φυσιολογικό τοίχωμα, άνηχο αυλό].

Συμπέρασμα: Στο υπερηχογράφημα ουροποιητικού δεν διαπιστώνεται παθολογία.

093 Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς · Φυσιολογικό

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με ερώτημα θυρεοειδικής δυσλειτουργίας ή ψηλαφητής διόγκωσης στα οποία δεν βλέπετε παθολογία.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς και τραχήλου· γραμμική κεφαλή υψηλής συχνότητας.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ο θυρεοειδής αδένας φυσιολογικού μεγέθους με ομοιογενή ηχογένεια παρεγχύματος. Δεν παρατηρούνται όζοι. Η αγγείωση στο έγχρωμο Doppler είναι φυσιολογική. Δεν διαπιστώνονται λεμφαδένες τραχήλου παθολογικής εμφάνισης.

Συμπέρασμα: Δεν διαπιστώθηκε παθολογία στο υπερηχογράφημα θυρεοειδούς.

094 Φλεβικό Doppler κάτω άκρων · Φυσιολογικό

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Πότε χρησιμοποιείται: Φλεβικά Doppler σε υποψία DVT στα οποία δεν βλέπετε θρόμβωση.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] φλεβικό υπερηχογράφημα Doppler κάτω άκρου· συμπίεση σε κλίμακα του γκρι, έγχρωμο και φασματικό Doppler.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Η κοινή μηριαία, η μηριαία και η ιγνυακή φλέβα συμπιέζονται πλήρως· δεν παρατηρείται θρόμβος στον αυλό τους. Στο έγχρωμο Doppler η πλήρωση του αυλού είναι πλήρης· στη φασματική ανάλυση υπάρχει αναπνευστική διακύμανση και απάντηση στη δοκιμασία ενίσχυσης ροής.
[Οι φλέβες της γαστροκνημίας εκτιμήθηκαν/δεν εκτιμήθηκαν].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] κάτω άκρο [στις εν τω βάθει φλέβες] δεν διαπιστώνεται θρόμβωση.

095 eFAST · Αρνητικό

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά ασθενών με τραύμα στα οποία δεν βλέπετε ελεύθερο υγρό ούτε πνευμοθώρακα στο eFAST παρά την κλίνη.

Τεχνική: eFAST παρά την κλίνη.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν παρατηρείται ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison, στον σπληνονεφρικό χώρο και στην πύελο. Δεν υπάρχει περικαρδιακή συλλογή στην υποξιφοειδή λήψη. Παρατηρείται αμφοτερόπλευρα ολίσθηση του πνεύμονα (lung sliding).

Συμπέρασμα: Στο eFAST δεν διαπιστώνονται ευρήματα υπέρ ελεύθερου υγρού, περικαρδιακής συλλογής ή πνευμοθώρακα. Το αρνητικό eFAST δεν αποκλείει κάκωση οργάνου· ανάλογα με την κλινική εικόνα συνιστάται αξονική τομογραφία.

096 Υπερηχογράφημα κοιλίας · Χολολιθίαση

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε ηχογενή εστία με ακουστική σκιά στη χοληδόχο κύστη.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα κοιλίας· σε κατάσταση νηστείας.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στον αυλό της χοληδόχου κύστης, η μεγαλύτερη [.. mm] μεγέθους, ηχογενείς εστίες με οπίσθια ακουστική σκιά, κινητές με την αλλαγή θέσης. Πάχος τοιχώματος [φυσιολογικό/αυξημένο]. Περιχολοκυστικό υγρό [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Υπερηχογραφικό σημείο Murphy [αρνητικό/θετικό]. Χοληδόχος πόρος [.. mm].

Συμπέρασμα: Χολολιθίαση. Ευρήματα οξείας χολοκυστίτιδας [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε].

097 Υπερηχογράφημα κοιλίας · Οξεία χολοκυστίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με πόνο στο δεξιό άνω τεταρτημόριο, πυρετό και υπερηχογραφικό σημείο Murphy.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα κοιλίας.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Χοληδόχος κύστη διατεταμένη, με παχυσμένο τοίχωμα [και οιδηματώδες, διπλό περίγραμμα]· στην περιοχή του αυχένα [.. mm] λίθος. Περιχολοκυστικό υγρό [υπάρχει]. Θετικό υπερηχογραφικό σημείο Murphy.

Συμπέρασμα: Ευρήματα συμβατά με οξεία λιθιασική χολοκυστίτιδα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

098 Υπερηχογράφημα ουροποιητικού · Υδρονέφρωση

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου στη λαγόνα, κωλικού νεφρού ή νεφρικής δυσλειτουργίας στα οποία βλέπετε διάταση του αποχετευτικού συστήματος.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα ουροποιητικού.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] νεφρός: [ήπια/μέτρια/έντονη] πυελοκαλυκική διάταση· εγγύς ουρητήρας [διατεταμένος/δεν απεικονίζεται]. Πάχος παρεγχύματος [διατηρημένο/λεπτυσμένο]. Ως αιτία απόφραξης [λίθος .. mm στην ουρητηροκυστική συμβολή/δεν αναγνωρίζεται σαφής αιτία]. Ουροδόχος κύστη [..].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [ήπια/μέτρια/έντονη] υδρονέφρωση· [πιθανή αιτία]. Εάν η αιτία δεν είναι σαφής, συνιστάται συσχέτιση με αξονική τομογραφία χωρίς σκιαγραφικό.

099 FAST · Ελεύθερο υγρό στον θύλακο του Morison

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά ασθενών με τραύμα στα οποία βλέπετε ελεύθερο υγρό στο FAST. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: FAST παρά την κλίνη.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στον θύλακο του Morison [και στη σπληνονεφρική περιοχή/στην πύελο] άνηχο ελεύθερο υγρό. Περικαρδιακή συλλογή [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: FAST θετικό: [στον θύλακο του Morison] ελεύθερο υγρό. Επείγουσα κλινική αξιολόγηση ανάλογα με την αιμοδυναμική κατάσταση· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

100 Υπερηχογράφημα θώρακα · Πλευριτική συλλογή

Πότε χρησιμοποιείται: Υποψία συλλογής στην ακτινογραφία ή προσδιορισμός ποσότητας και θέσης πριν από θωρακοκέντηση.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα θώρακα· [σε καθιστή θέση], μεσοπλεύρια σάρωση.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά/Αμφοτερόπλευρα] υπεζωκοτική κοιλότητα: [άνηχο/με ηχογενές περιεχόμενο/με διαφραγμάτια] υγρό· στο μεγαλύτερο βάθος [.. mm]. Συμπιεστική ατελεκτασία του παρακείμενου πνεύμονα. [Δεν παρατηρείται υπεζωκοτική οζωσία.]

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [άνηχη/επιπεπλεγμένης εμφάνισης] υπεζωκοτική συλλογή. [Σημειώθηκε κατάλληλο παράθυρο για θωρακοκέντηση.]

101 Υπερηχογράφημα πνεύμονα · Γραμμές Β

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά ασθενών με δύσπνοια στα οποία βλέπετε γραμμές Β στο υπερηχογράφημα πνεύμονα παρά την κλίνη.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα πνεύμονα παρά την κλίνη· αμφοτερόπλευρη σάρωση ανά περιοχή.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Αμφοτερόπλευρα [πρόσθια και πλάγια] περιοχές: πολλαπλές γραμμές Β σε κάθε περιοχή. Υπεζωκοτική γραμμή [ομαλό/ανώμαλο και παχυσμένο]. Πλευριτική συλλογή [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Αμφοτερόπλευρες διάχυτες γραμμές Β· συμβατές με διάμεσο σύνδρομο. Σε συνδυασμό με ομαλή υπεζωκοτική γραμμή μπορεί να υποδηλώνουν καρδιογενές πνευμονικό οίδημα· συνιστάται κλινική και υπερηχοκαρδιογραφική συσχέτιση.

102 Φλεβικό Doppler · Εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά ασθενών με οίδημα και πόνο στο κάτω άκρο στα οποία βλέπετε φλέβα που δεν συμπιέζεται. Απαιτείται ενημέρωση.

Τεχνική: [Δεξιά/Αριστερά] φλεβικό υπερηχογράφημα Doppler κάτω άκρου.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Κοινή μηριαία/μηριαία/ιγνυακή] φλέβα: δεν συμπιέζεται· [μερικώς/πλήρως] ηχογενής θρόμβος που πληροί τον αυλό· στο έγχρωμο Doppler [απουσία ροής/μερική ροή]. Θρόμβος [εγγύς όριο: ..].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [μηροϊγνυακό] τμήμα: ευρήματα συμβατά με οξεία εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

103 Υπερηχογράφημα δεξιού κάτω τεταρτημορίου · Οξεία σκωληκοειδίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με φλεγμαίνουσα σκωληκοειδή απόφυση σε παιδί, νέο ή έγκυο ασθενή με άλγος στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα δεξιού κάτω τεταρτημορίου· τεχνική βαθμιαίας συμπίεσης.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στο δεξιό κάτω τεταρτημόριο, μη συμπιεστή, [.. mm] διαμέτρου τυφλή σωληνοειδής δομή (σκωληκοειδής απόφυση)· στο έγχρωμο Doppler αυξημένη αγγείωση του τοιχώματος. Αυξημένη ηχογένεια του περιβάλλοντος λίπους. Κοπρόλιθος σκωληκοειδούς [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Περισκωληκοειδικό υγρό [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Ευρήματα συμβατά με οξεία σκωληκοειδίτιδα. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα]. / Η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίστηκε· αυτό δεν αποκλείει τη σκωληκοειδίτιδα.

104 Υπερηχογράφημα κοιλιακής αορτής · Ανεύρυσμα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά προσυμπτωματικού ελέγχου, σφύζουσας μάζας ή κοιλιακού-οσφυϊκού πόνου στα οποία βλέπετε διάταση της αορτής.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα κοιλιακής αορτής· εγκάρσιες και επιμήκεις μετρήσεις.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στην υπονεφρική κοιλιακή αορτή, μέγιστης [.. mm] διαμέτρου ανευρυσματική διάταση· στον αυλό [τοιχωματικός θρόμβος]. Περιαορτικό υγρό [δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε].

Συμπέρασμα: Ανεύρυσμα υπονεφρικής κοιλιακής αορτής, μέγιστη διάμετρος [.. mm]. Σε συμπτωματικό ασθενή η ρήξη δεν μπορεί να αποκλειστεί με υπερηχογράφημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα]· συνιστάται αξονική αγγειογραφία.

105 Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς · Όζος θυρεοειδούς

Πότε χρησιμοποιείται: Ψηλαφητός όζος ή τυχαίος όζος θυρεοειδούς.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς· γραμμική κεφαλή, έγχρωμο Doppler.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Θυρεοειδής [δεξιά/αριστερά] λοβός [άνω/μέσο/κάτω] μοίρα [.. x .. x .. mm] μεγέθους, [συμπαγής/κυστική/μικτή], [υποηχογενής/ισοηχογενής/υπερηχογενής], [ομαλά/ανώμαλα] περιγεγραμμένος όζος. Μικροασβεστώσεις [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. [Κάθετος προσανατολισμός μακρού άξονα: όχι/ναι]. Παθολογικοί λεμφαδένες τραχήλου [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: Θυρεοειδής [δεξιός λοβός]: [.. mm] όζος· σύμφωνα με την ταξινόμηση κινδύνου που χρησιμοποιεί το ίδρυμά σας: [κατηγορία]. Η ανάγκη βιοψίας με αναρρόφηση λεπτής βελόνας και παρακολούθησης πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με αυτή την ταξινόμηση.

106 Υπερηχογράφημα κοιλίας · Ηπατική στεάτωση

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά στα οποία βλέπετε διάχυτη αύξηση της ηχογένειας του ηπατικού παρεγχύματος.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα κοιλίας.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ήπαρ [φυσιολογικού μεγέθους/διογκωμένο]· διάχυτα αυξημένη ηχογένεια του παρεγχύματος σε σχέση με τον νεφρικό φλοιό· τοιχώματα πυλαίων φλεβών και διάφραγμα [διακρίνονται/δεν διακρίνονται]. Δεν παρατηρείται εστιακή βλάβη.

Συμπέρασμα: [Ήπια/Μέτρια/Έντονη] εικόνα συμβατή με ηπατική στεάτωση.

107 Υπερηχογράφημα πυέλου · Υποψία έκτοπης κύησης

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά ασθενών με θετικό τεστ κύησης στα οποία δεν απεικονίζεται ενδομήτρια κύηση. Απαιτείται ενημέρωση.

Τεχνική: Διακοιλιακό [και διακολπικό] υπερηχογράφημα πυέλου.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Δεν απεικονίζεται σάκος κύησης στην ενδομήτρια κοιλότητα. [Δεξιά/Αριστερά] εξαρτήματα, χωριστά από την ωοθήκη, [.. mm] ετερογενής μάζα [/με λεκιθικό ασκό ή έμβρυο]. Στον χώρο του Douglas [με ηχογενές περιεχόμενο] ελεύθερο υγρό [υπάρχει/δεν υπάρχει].

Συμπέρασμα: Δεν απεικονίζεται ενδομήτρια κύηση· [δεξιά/αριστερά] μάζα εξαρτημάτων και [ελεύθερο υγρό]· ευρήματα υπέρ εξωμήτριας κύησης. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

108 Υπερηχοκαρδιογραφικό παράθυρο / POCUS · Περικαρδιακή συλλογή

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά δύσπνοιας, υπότασης ή τραύματος στα οποία βλέπετε περικαρδιακό υγρό στην υποξιφοειδή λήψη.

Τεχνική: Παρά την κλίνη υποξιφοειδής **[και παραστερνική]** απεικόνιση.

Σύγκριση: **[ημερομηνία]** (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Στον περικαρδιακό χώρο **[περιμετρικό/εντοπισμένο]** άνηχο υγρό· στο μεγαλύτερο εύρος **[.. mm]**. Διαστολική σύμπτωση δεξιού κόλπου/δεξιάς κοιλίας **[δεν παρατηρήθηκε/παρατηρήθηκε]**.

Συμπέρασμα: **[Μικρή/Μέτρια/Μεγάλη]** περικαρδιακή συλλογή. Ευρήματα υπέρ επιπωματισμού **[δεν υπάρχουν/υπάρχουν· αναφέρθηκαν ως επείγον εύρημα]**. Για λεπτομερή εκτίμηση συνιστάται υπερηχοκαρδιογράφημα.

109 Υπερηχογράφημα ουροποιητικού · Απλή νεφρική κύστη

Πότε χρησιμοποιείται: Τυχαίες, άνηχες νεφρικές βλάβες.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα ουροποιητικού.

Σύγκριση: **[ημερομηνία]** (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: **[Δεξιά/Αριστερά]** νεφρός **[άνω/μέσο/κάτω]** πόλος: **[.. mm]** μεγέθους λεπτότοιχη, άνηχη κύστη με οπίσθια ακουστική ενίσχυση, χωρίς διαφραγμάτια ή συμπαγές στοιχείο.

Συμπέρασμα: **[Δεξιά/Αριστερά]** νεφρός: βλάβη συμβατή με απλή φλοιώδη κύστη.

110 Υπερηχογράφημα κοιλίας · Απόστημα ήπατος

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με πυρετό και πόνο στο δεξιό άνω τεταρτημόριο στα οποία βλέπετε επιπεπλεγμένη κυστική βλάβη στο ήπαρ.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα κοιλίας· έγχρωμο Doppler.

Σύγκριση: **[ημερομηνία]** (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: Ηπατικό τμήμα **[..]**: **[.. mm]** μεγέθους, με ανώμαλο τοίχωμα, εσωτερικές ηχώ και **[ηχογενές υπόλειμμα]** υποηχογενής/σύνθετη κυστική βλάβη· περιφερικά **[υπεραιμία]**.

Συμπέρασμα: Ηπατικό τμήμα **[..]**: βλάβη πιθανώς συμβατή με απόστημα. Συνιστάται κλινική και εργαστηριακή συσχέτιση· εφόσον χρειάζεται, αξονική τομογραφία με σκιαγραφικό. Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις **[ώρα]**.

111 Doppler οσχέου · Υποψία συστροφής όρχεως

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά αιφνίδιου πόνου στο όσχεο στα οποία βλέπετε μειωμένη ροή στον προσβεβλημένο όρχι. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα οσχέου σε κλίμακα του γκρι και έγχρωμο/φασματικό Doppler· συγκριτικά με τον ετερόπλευρο όρχι.

Σύγκριση: **[ημερομηνία]** (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: **[Δεξιά/Αριστερά]** όρχις **[διογκωμένος, ανομοιογενής]**· ενδοορχική ροή στο έγχρωμο Doppler **[δεν παρατηρείται/σημαντικά μειωμένη σε σχέση με την αντίθετη πλευρά]**. Στον σπερματικό τόνο **[σημείο στροβίλου]**. Ο ετερόπλευρος όρχις είναι φυσιολογικός.

Συμπέρασμα: **[Δεξιά/Αριστερά]** ευρήματα συμβατά με συστροφή όρχεως. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις **[ώρα]**. Η παρουσία ροής δεν αποκλείει πλήρως τη συστροφή.

112 Υπερηχογράφημα κοιλίας · Ασκίτης

Πότε χρησιμοποιείται: Διόγκωση της κοιλίας ή εκτίμηση υγρού πριν από παρακέντηση.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα κοιλίας.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: Εντός της κοιλίας, στην περιηπατική, περισπληνική και πυελική περιοχή [μικρή/μέτρια/μεγάλη] ποσότητα [άνηχο/με ηχογενές περιεχόμενο/με διαφραγμάτια] ελεύθερο υγρό. Περίγραμμα ήπατος [ομαλό/οζώδες].

Συμπέρασμα: [Μικρή/Μέτρια/Μεγάλη] ποσότητα ασκιτικού υγρού.
[Σημειώθηκε κατάλληλο παράθυρο για παρακέντηση.]

113 Υπερηχογράφημα μαστού · Απλή κύστη

Πότε χρησιμοποιείται: Υπερηχογραφική εκτίμηση ψηλαφητής μάζας ή βλάβης που ανιχνεύθηκε στη μαστογραφία.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα αμφοτέρων των μαστών· γραμμική κεφαλή.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] μαστός, στη θέση της ώρας [..] , σε απόσταση από τη θηλή [.. cm] , [.. mm] μεγέθους ωοειδής, άνηχη βλάβη με ομαλά όρια και οπίσθια ακουστική ενίσχυση.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] μαστός: βλάβη συμβατή με απλή κύστη· σύμφωνα με την ταξινόμηση που χρησιμοποιεί το ίδρυμά σας: [κατηγορία].

114 Doppler καρωτίδων · Αθηρωματική πλάκα

Πότε χρησιμοποιείται: Αξιολόγηση καρωτίδων σε αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή έλεγχο αγγειακού κινδύνου.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα Doppler αμφοτερόπλευρα των καρωτίδων και των σπονδυλικών αρτηριών.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] [κοινή καρωτίδα/βολβός/έσω καρωτίδα] αρτηρία: [με επασβεστώσεις/υποηχογενής/ανομοιογενής] αθηροσκληρωτική πλάκα. Μέγιστη συστολική ταχύτητα ροής στο επίπεδο της πλάκας [.. cm/s]. Ροή στις σπονδυλικές αρτηρίες [ορθόδρομη].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [έσω καρωτίδα] αρτηρία: αθηροσκληρωτική πλάκα· βαθμός στένωσης σύμφωνα με τα κριτήρια Doppler που χρησιμοποιεί το ίδρυμά σας: [βαθμός]. Σε σημαντική στένωση συνιστάται συσχέτιση με αξονική ή μαγνητική αγγειογραφία.

115 Υπερηχογράφημα κοιλίας · Διάταση χοληδόχου πόρου

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά με αυξημένα ένζυμα χολόστασης ή ίκτερο στα οποία τα χοληφόρα είναι διατεταμένα.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα κοιλίας.
Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.
Ευρήματα: Χοληδόχος πόρος [.. mm] διαμέτρου, διατεταμένος· ενδοηπατικά χοληφόρα [διατεταμένα/μη διατεταμένα]. Στο περιφερικό τμήμα του χοληδόχου πόρου [λίθος .. mm/η αιτία της απόφραξης δεν διακρίνεται· το περιφερικό τμήμα δεν απεικονίζεται λόγω αερίων του εντέρου]. Στη χοληδόχο κύστη [λίθος υπάρχει/δεν υπάρχει].

Συμπέρασμα: Διάταση χοληδόχου πόρου· [πιθανή αιτία]. Εάν δεν προσδιοριστεί η αιτία, συνιστάται MRCP.

116 Υπερηχογράφημα ουροποιητικού · Νεφρολιθίαση

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου στη λαγόνα ή αιματουρίας στα οποία βλέπετε εστία με ακουστική σκιά στον νεφρό.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα ουροποιητικού.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] νεφρός [κάτω/μέσο/άνω] πόλος, κάλυκας: [.. mm] μεγέθους ηχογενής εστία με ακουστική σκιά (στο έγχρωμο Doppler, artefact σπινθηρισμού (twinkling) [υπάρχει]). Πυελοκαλυκικό σύστημα [μη διατεταμένο/διατεταμένο].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] νεφρός: [.. mm] λίθος· [χωρίς υδρονέφρωση/με συνοδό υδρονέφρωση].

117 POCUS πνεύμονα · Ευρήματα πνευμοθώρακα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μετά από τραύμα ή επέμβαση στα οποία δεν παρατηρείται ολίσθηση του πνεύμονα στο υπερηχογράφημα πνεύμονα παρά την κλίνη. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα πνεύμονα παρά την κλίνη· πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα, M-mode.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα: δεν παρατηρείται ολίσθηση του πνεύμονα (lung sliding)· απουσία γραμμών B. Στο M-mode [σημείο γραμμωτού κώδικα/σημείο στρατόσφαιρας]. Σημείο πνεύμονα (lung point) [παρατηρήθηκε/δεν παρατηρήθηκε].

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] ευρήματα υπέρ πνευμοθώρακα ([παρατηρήθηκε σημείο πνεύμονα]). Η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

118 Υπερηχογράφημα κοιλίας (παιδί) · Εγκολεασμός

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά μικρών παιδιών με διαλείποντα κοιλιακό πόνο και εμέτους στα οποία βλέπετε εικόνα στόχου. Επείγουσα ενημέρωση.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα κοιλίας· γραμμική και κυρτή κεφαλή.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιό άνω τεταρτημόριο/Δεξιό ημιμόριο της κοιλίας]: στην εγκάρσια τομή εικόνα στόχου (target), στην επιμήκη τομή εικόνα ψευδονεφρού, [.. mm] διαμέτρου εντερική έλικα. Εντός αυτής [λεμφαδένας/οδηγό σημείο] [δεν υπάρχουν/υπάρχουν]. Ροή τοιχώματος στο έγχρωμο Doppler [διατηρημένη/μειωμένη]. Ελεύθερο υγρό πέριξ [δεν υπάρχουν/υπάρχουν].

Συμπέρασμα: [Ειλεοκολική] εγκολεασμός: συμβατά ευρήματα. Επείγον εύρημα· η κλινική ομάδα ενημερώθηκε στις [ώρα].

119 Doppler οσχέου · Επιδιδυμοορχίτιδα

Πότε χρησιμοποιείται: Περιστατικά πόνου και διόγκωσης οσχέου στα οποία βλέπετε υπεραιμία της επιδιδυμίδας.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα οσχέου σε κλίμακα του γκρι και έγχρωμο Doppler.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Δεξιά/Αριστερά] επιδιδυμίδα [κεφαλή/σώμα] τμήμα διογκωμένο και ετερογενές· στο έγχρωμο Doppler σημαντικά αυξημένη αγγείωση. Όρχις: [υπεραιμία: ναι/όχι]. Αντιδραστική υδροκήλη [υπάρχει/δεν υπάρχει]. Ο ετερόπλευρος όρχις και η επιδιδυμίδα είναι φυσιολογικοί.

Συμπέρασμα: [Δεξιά/Αριστερά] [επιδιδυμίτιδα/επιδιδυμοορχίτιδα]: συμβατά ευρήματα. Η ορχική ροή διατηρείται.

120 Υπερηχογράφημα μαλακών μορίων · Απόστημα

Πότε χρησιμοποιείται: Διερεύνηση συλλογής σε περιστατικά με διόγκωση, ερυθρότητα και πόνο στο υποδόριο.

Τεχνική: Υπερηχογράφημα επιφανειακών μαλακών μορίων· γραμμική κεφαλή, έγχρωμο Doppler.

Σύγκριση: [ημερομηνία] (ημερομηνία προηγούμενης εξέτασης): έγινε σύγκριση. / Δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση για σύγκριση.

Ευρήματα: [Περιοχή]: στον υποδόριο λιπώδη ιστό [.. mm] μεγέθους υποηχογενής συλλογή, με ασαφή όρια, εσωτερικές ηχώ και περιεχόμενο που μετακινείται με τη συμπίεση· περιφερικά αυξημένη αγγείωση και οίδημα (εικόνα λιθόστρωτου).

Συμπέρασμα: [Περιοχή]: συλλογή συμβατή με απόστημα μαλακών μορίων και ευρήματα περιβάλλουσας κυτταρίτιδας.

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Ανοίξτε τώρα το Μπόνους 1 · Τράπεζα 200 Συμπερασμάτων Γνωμάτευσης. Το πιο δύσκολο μέρος του προτύπου είναι το πεδίο Συμπέρασμα· με τις προτάσεις της τράπεζας για φυσιολογικά, τυχαία και επείγοντα ευρήματα, κλείστε κάθε γνωμάτευση με μία μόνο, σαφή πρόταση.

Πριν από την υπογραφή **Γρήγορο μπόνους · Λίστα Ελέγχου Γνωμάτευσης σε Μία Σελίδα**: κρατήστε τη δίπλα σας.